

1. Autor responsable:

- 1.1. Nombres y apellidos: Karina Juliana Paredes Aco
- 1.2. Correo electrónico: a2020200935@uwiener.edu.pe

2. Docente/ Asesor

- 2.1. Nombres y apellidos: Mg. Sofía Del Carpio Flórez

3. Facultad y Programa Académico:

- 3.1. Facultad: Ciencias de la Salud
- 3.2. Programa Académico de Enfermería

4. Línea y sublínea de investigación

4.1. Línea: Innovación en salud integral y gestión sanitaria para la mejora de la calidad y equidad en la atención.

4.2. Sublínea: Atención primaria y promoción de la salud

5. Institución en la que se ejecutará el proyecto: Centro de Salud Mirones

6. Título del proyecto:

“Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”

7. Resumen

La ausencia de las madres en los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) compromete la identificación oportuna de alteraciones en el desarrollo infantil, y se encuentra asociada a variables como las condiciones económicas, el nivel educativo, las prácticas culturales y las dificultades de acceso a los servicios de salud. Una investigación reportó que el 73,5% de las madres no cumplieron con dichos controles, siendo las causas

más frecuentes el desconocimiento sobre la periodicidad requerida (76,0%), la carencia de información adecuada (60,0%) y las cargas del trabajo doméstico (56,0%). Atender estas problemáticas resulta esencial para fomentar una mayor participación y promover el bienestar integral de los niños. **objetivo:** “Determinar cómo los factores asociados se relacionan con incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”. **Material y método:** El presente estudio se enmarcó dentro del método hipotético-deductivo, empleando un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra estuvo conformada por un total de 106 madres teniendo como muestra 83 madres de niños menores de 1 año. Para la recolección de información, se utilizó un cuestionario .El instrumento fue elaborado por Chahuas Rodríguez en 2017; sin embargo, al tratarse de un cuestionario con más de 5 años de antigüedad, fue actualizado y ajustado por la investigadora en octubre de 2025, La confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante el coeficiente Kuder–Richardson 20 (KR-20), Aplicando la fórmula de KR-20, se obtuvo un coeficiente de 0.73, valor que se encuentra dentro del rango considerado aceptable (0.7–0.8). Este resultado indica que el instrumento posee una consistencia interna adecuada y es confiable para medir los factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de un año.

Palabras clave: Factores asociados, incumplimiento, crecimiento y desarrollo, niños, madres.

Abstract

The absence of mothers from growth and development monitoring (CRED) appointments compromises the timely identification of developmental alterations in children and is associated with factors such as economic conditions, educational level, cultural practices, and difficulties in accessing health services. One study reported that 73.5% of mothers did not comply with these controls, with the most frequent causes being a lack of knowledge about the required periodicity (76.0%), insufficient information (60.0%), and the burden of domestic work (56.0%). Addressing these issues is essential to promote greater participation and foster the overall well-being of children. **Objective:** To determine the relationship between associated factors and noncompliance with growth and development

monitoring among mothers of children under one year of age in a health center in Lima, 2025. **Materials and Methods:** This study was conducted within a hypothetico-deductive framework, employing a quantitative approach with a descriptive correlational and cross-sectional design. The initial population consisted of 106 mothers, from which a sample of 83 mothers of children under one year of age was selected. Data were collected using a structured questionnaire. The instrument was originally developed by Chahuas Rodríguez in 2017; however, given that it was more than five years old, it was updated and adapted by the researcher in October 2025. The reliability of the questionnaire was assessed using the Kuder–Richardson 20 (KR-20) coefficient. Applying the KR-20 formula yielded a coefficient of 0.73, which falls within the acceptable range (0.7–0.8). This result indicates that the instrument has adequate internal consistency and is reliable for measuring the factors associated with noncompliance with growth and development monitoring among mothers of children under one year of age.

Keywords: Factors, Non-adherence, Compliance, Growth and Development monitoring, Children, Mother.

8. Contextualización del problema

8.1. Planteamiento problema:

El control de crecimiento y desarrollo (CRED) constituye una herramienta esencial utilizada por los servicios de salud para supervisar el estado nutricional, el desarrollo físico y las habilidades psicomotoras de los niños menores de cinco años, con especial atención al primer año de vida, etapa en la que los menores son más vulnerables. La participación regular en estos controles permite identificar a tiempo posibles problemas de salud, facilitando una intervención precoz que ayuda a reducir las tasas de enfermedad y mortalidad infantil (1).

Según la Organización Mundial de la Salud, el seguimiento del crecimiento y desarrollo en la infancia es crucial para prevenir enfermedades y disminuir la mortalidad infantil. No obstante, en entornos con recursos escasos, la asistencia reducida a los controles se ve influenciada por diversos factores, entre ellos la distancia a los establecimientos de salud,

las limitaciones económicas, la falta de conocimiento por parte de los cuidadores y deficiencias en la calidad de la atención brindada (2).

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el informe Estado Mundial de la Infancia 2019 indica que cerca de 149 millones de niños menores de cinco años —equivalente al 21,9% de esa población— presentan retrasos en su crecimiento. En regiones de ingresos bajos y medios, más del 43% de los menores están expuestos al riesgo de no alcanzar un desarrollo pleno, situación influenciada por factores como la pobreza, la malnutrición y la carencia de servicios esenciales. Las condiciones socioeconómicas precarias, el bajo nivel de escolaridad de las madres, las barreras culturales y geográficas, así como las deficiencias estructurales en los sistemas de salud, dificultan significativamente la participación en los controles de crecimiento y desarrollo. Esta falta de acceso limita la identificación temprana de alteraciones durante la infancia, retrasa intervenciones fundamentales y perpetúa ciclos de desigualdad y exclusión social (3).

En diversas regiones de América Latina y África, la escasa infraestructura, la insuficiente disponibilidad de servicios de salud y el desconocimiento sobre la relevancia del control infantil temprano representan obstáculos para la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, lo que compromete el bienestar y la salud de la infancia (4). Así mismo en Nepal, El 85.5% de las madres no asisten a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) debido a la falta de disponibilidad de tiempo, ya que gran parte de su jornada está dedicada a las tareas del hogar y al cuidado de la familia (5). En la región noroccidental de Etiopía, aproximadamente el 35% de los cuidadores presentaban dificultades para interpretar las gráficas de crecimiento infantil debido a diferencias lingüísticas, ya que la información estaba redactada en amárico e inglés, mientras que la mayoría, un 62%, utilizaba el awigna como lengua principal (6).

En el Perú, el gobierno ha puesto en marcha diversas iniciativas orientadas a disminuir la mortalidad infantil y promover la salud en niños menores de un año, entre las cuales destacan las normas establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA) para el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil. No obstante, la falta de cumplimiento con estos

controles aún es frecuente, especialmente en áreas rurales y marginadas. Entre los principales obstáculos se encuentran la dificultad para acceder a los servicios de salud, la sobrecarga en los establecimientos, la falta de conocimiento sobre la importancia de estas evaluaciones, así como las condiciones socioeconómicas de las madres, como su nivel de instrucción, responsabilidades laborales y escasez de tiempo. A ello se suma la percepción desfavorable sobre la calidad y accesibilidad del servicio, lo que limita aún más la participación en estas actividades preventivas (7).

Por su parte el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), durante el año 2023, únicamente el 68.5% de los niños menores de un año lograron cumplir con sus controles de crecimiento y desarrollo en los establecimientos públicos de salud a nivel nacional. En el caso de Lima Metropolitana, la cobertura fue ligeramente superior, alcanzando el 72.1%; sin embargo, esta cifra continúa por debajo del objetivo del 85% fijado por las políticas de salud pública del Ministerio de Salud (8).

En el contexto local, específicamente en el Centro de Salud Mirones, ubicado en el distrito de Lima, se ha identificado que una parte considerable de las madres no acude de forma constante a los controles de crecimiento y desarrollo establecidos. Según los datos del padrón nominal 2024, menos del 70% de los niños menores de un año completaron dichos controles, cifra inferior a la meta planteada por el Ministerio de Salud (85%). Esta situación limita la detección oportuna de alteraciones en la salud infantil y afecta el bienestar integral de los niños. Ante esta problemática, surge la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo (CRED) en madres de niños menores de 1 año en el Centro de Salud Mirones, Lima, 2025? El presente estudio tiene como finalidad identificar los factores sociodemográficos, económicos, culturales e institucionales que inciden en la asistencia a los controles CRED, con el propósito de proponer estrategias que fortalezcan la adherencia y mejoren la calidad de la atención en salud infantil.

8.2. Formulación de problema:

¿Cómo los factores asociados se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025?

Problemas específicos

¿Cómo la dimensión factores socioeconómicos se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025?

¿Cómo la dimensión factores culturales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año de un centro de salud de Lima, 2025?

¿Cómo la dimensión factores institucionales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año de un centro de salud de Lima, 2025?

8.3. Justificación:

La presente investigación, titulada “Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”, se enmarca dentro de las estrategias prioritarias en salud pública que buscan garantizar un desarrollo pleno en la infancia temprana. Estas acciones abarcan dimensiones físicas, emocionales y cognitivas, y contribuyen a prevenir enfermedades mediante intervenciones oportunas. No obstante, a pesar de la existencia de normativas vigentes y la disponibilidad gratuita de estos servicios en los centros de atención primaria, persiste una baja adherencia por parte de las madres, lo que refleja una problemática estructural aún no resuelta por el sistema sanitario.

Desde el ámbito académico, esta investigación reviste importancia al permitir la exploración y comprensión de los elementos que influyen en el incumplimiento de los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Su aporte se traduce en evidencia útil para fortalecer los saberes en áreas clave como la salud pública, la atención primaria y el desarrollo integral de la primera infancia. Asimismo, proporciona una mirada situada que representa fielmente las condiciones de sectores urbanos caracterizados por una alta vulnerabilidad social, como ocurre en determinadas zonas de Lima.

En el plano aplicado, los hallazgos obtenidos podrán servir de base para diseñar intervenciones más adecuadas dirigidas al personal sanitario, las autoridades territoriales y los agentes comunitarios. Tales intervenciones podrían incluir iniciativas de formación, campañas de concienciación y acciones que mejoren el acceso efectivo a los servicios destinados a la niñez. En conjunto, estas medidas facilitarían un aumento en la asistencia a los controles CRED, la disminución de enfermedades y muertes infantiles, y el fomento de un desarrollo infantil equitativo y saludable.

En conclusión, la factibilidad de la presente investigación se sustenta en la posibilidad real de interactuar con la población de interés, el acceso a fuentes de información confiables y el soporte brindado por las instituciones correspondientes. Su relevancia se manifiesta en el potencial efecto favorable sobre el bienestar infantil, la promoción de la autonomía materna y el reforzamiento del primer nivel de atención en salud.

8.4. Objetivo general y específicos:

Objetivo general

Determinar cómo los factores asociados se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima ,2025.

Objetivos específicos

Identificar como la dimensión factores socioeconómicos se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025

Identificar como la dimensión factores culturales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025

Identificar como la dimensión factores institucionales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año de un centro de salud de Lima, 2025

8.4. Hipótesis:

Hipótesis general:

H₁:

Existe una relación entre los factores asociados y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.

H₀:

No existe una relación entre los factores asociados y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.

Hipótesis específicas:

H₁: Existe una relación entre la dimensión factores sociodemográficos y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.

H2: Existe una relación entre la dimensión factores culturales y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.

H3: Existe una relación entre la dimensión factores institucionales y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.

9. Marco teórico

9.1. Antecedentes:

Antecedentes Nacionales

Según lo señalado por Orosco y Ramírez (9) en el año 2022, se desarrolló una investigación en la ciudad de Lima con el objetivo de “Determinar la relación entre los factores socioculturales y la inasistencia de madres al control de crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años en un Centro de Salud, Lima-2022”. La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y un nivel de alcance correlacional-descriptivo. Se examinó a una muestra conformada por 73 madres que no acudieron a los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) durante el mes de agosto. Para la recolección de datos, se aplicó un instrumento de 18 ítems elaborado por Enríquez Nazario y Pedraza Bela, el cual fue sometido a validación por juicio de expertos y presentó un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,623, superando el umbral mínimo aceptable ($\alpha > 0,6$). El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS versión 26. Los hallazgos revelan que, en el ámbito social, el 34,2 % de las participantes tenía entre 25 y 29 años, el 47,9 % tenía un solo hijo, el 45,2 % se dedicaba exclusivamente a labores del hogar y el 27,4 % contaba con un empleo eventual. Asimismo, el 54,8 % manifestaba que su desplazamiento al establecimiento de salud tomaba aproximadamente 10 minutos, y el 46,6 % reportaba ingresos mensuales entre 850 y 1000 soles. En lo referente a los factores culturales, el 63 % de las madres había alcanzado el nivel secundario de educación. El 42,5 % identificaba el control CRED como una medida preventiva, mientras que un 34,2 % no asistía al considerar que su hijo se encontraba

saludable. Un 20,5 % expresó que sus responsabilidades laborales dificultaban la asistencia. Además, el 54,8 % no había recibido materiales educativos sobre el tema, y el 68,3 % percibía como innecesario acudir a dichos controles. Como conclusión, el estudio evidenció una asociación significativa entre las variables socioculturales y la inasistencia de las madres a los controles CRED en un establecimiento de salud de Lima durante el año 2022.

Roldan (10). En el año 2022, llevó a cabo un estudio en la ciudad de Lima con el propósito de “Determinar los factores asociados al incumplimiento de las madres al control de CRED del niño(a) menor de un año en un Centro de Salud, Lima – Perú 2022”. La presente investigación, basada en un enfoque cuantitativo y desarrollada bajo un diseño descriptivo de tipo transversal, abordó el análisis de 161 madres con hijos menores de un año. Para la recolección de datos, se empleó un cuestionario estructurado aplicado mediante encuestas, el cual fue organizado en tres dimensiones analíticas: socioeconómica, cultural e institucional. En cuanto a los aspectos socioeconómicos, se identificaron como principales obstáculos la carga de tareas domésticas (65 %), la participación en actividades laborales (57 %), el cuidado de otros hijos (54 %) y la incompatibilidad con los horarios de trabajo (52 %). Dentro de la dimensión cultural, un 56 % de las participantes manifestó no tener conocimiento sobre la necesidad de dar continuidad a los controles, mientras que un 54 % señaló no comprender su relevancia. Respecto a los factores institucionales, los resultados revelaron que el 76,4 % de las madres percibieron inconvenientes en los horarios de atención, el 64 % reportó deficiencias en el proceso de admisión, y el 62,7 % expresó molestias por el tiempo de espera excesivo. Asimismo, el 57,8 % indicó que la información proporcionada por el personal de enfermería fue insuficiente, y el 50,9 % refirió que no se les explicó adecuadamente la importancia de los controles CRED. Como conclusión, el estudio establece que los determinantes institucionales y socioeconómicos tienen una influencia significativa en la inasistencia de madres a los controles de crecimiento y desarrollo en niños menores de un año.

Requejo (11). En el año 2022 llevó a cabo un estudio en la ciudad de Lima que tuvo como Objetivo: “Sistematizar las evidencias bibliográficas de los estudios sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres de los niños al control de crecimiento y

desarrollo en el periodo 2012-2020” La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, empleando un diseño retrospectivo acompañado de una revisión sistemática de la literatura científica. La muestra estuvo compuesta por 40 artículos académicos que abordaban los factores maternos vinculados a la inasistencia a los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Estos documentos fueron seleccionados de bases de datos reconocidas, tales como Scielo, Dialnet, Redalyc, ResearchGate y Renati. En los hallazgos, se observó que el 55 % de las publicaciones revisadas pertenecían a revistas indexadas, siendo Scielo una de las más representativas. Asimismo, el 80 % de los estudios estaban redactados en idioma español. El año con mayor concentración de investigaciones fue 2018, con un 25 % del total, mientras que el 75 % de los artículos analizados presentó una baja calidad de evidencia, en función del diseño metodológico aplicado. En cuanto a los factores sociodemográficos, se identificaron como determinantes principales la edad materna y el rol de ama de casa. En el ámbito institucional, la principal causa asociada al abandono de los controles fue el tiempo de espera prolongado para recibir atención médica. Finalmente, en la dimensión cultural, se destacó que un bajo nivel educativo en las madres constituía una limitación importante para su participación en los programas de control CRED.

Magallan (12). En el año 2024 en la ciudad de Lima, realizó una investigación que tuvo como Objetivo: “Determinar los factores sociodemográficos e institucionales asociados al cumplimiento de las madres al servicio de CRED en niños menores de 5 años en el C.M.I Tahuantinsuyo Bajo, 2024”. La investigación fue desarrollada mediante una metodología de tipo básica, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de carácter transversal. La muestra estuvo compuesta por 80 madres de niños menores de cinco años que asistieron al Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo. Para la obtención de datos, se aplicó el cuestionario titulado “Factores relacionados con la asistencia de las madres a los controles de crecimiento saludable en menores de cinco años”, el cual fue previamente validado y alcanzó un nivel de confiabilidad del 0,98 %. Los resultados mostraron que el 78,7 % de las madres no asistía de manera regular a los controles de CRED de sus hijos. Entre las variables sociodemográficas, se identificó que el nivel educativo ($p > 0.030$) y la edad del menor ($p > 0.037$) tuvieron mayor peso en el comportamiento observado. En cuanto a los factores institucionales, se evidenció una relación entre la frecuencia de

asistencia y los horarios de atención ofrecidos ($p > 0.022$), según los resultados obtenidos mediante la prueba estadística Chi cuadrado ($p < 0.05$). Como conclusión general, se determinó que los factores sociodemográficos e institucionales no presentan una asociación estadísticamente significativa con el cumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo infantil.

Quispe (13). En el año 2022 en Ica realizó una investigación que tuvo como Objetivo: “Determinar los factores relacionados al incumplimiento del control de CRED en niños menores de 5 años en el periodo 2015-2020”. La presente investigación, desarrollada bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental, consistió en el análisis de 24 estudios previos, utilizando técnicas de observación y revisión documental como principales métodos de recolección de información. Los hallazgos permiten identificar que la inasistencia a los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) en menores de cinco años está relacionada con diversos factores de tipo sociodemográfico, cultural e institucional. Dentro de los factores sociodemográficos, se identificaron como más relevantes la edad tanto de la madre como del niño (34 %), el nivel socioeconómico bajo (29 %), la carga de tareas domésticas (29 %), la incompatibilidad con los horarios laborales y la cantidad de hijos (25 %), así como conflictos o problemas familiares (17 %). En cuanto a la dimensión cultural, el 63 % de los estudios señaló como limitantes el bajo nivel educativo de las madres, la falta de conocimiento sobre la importancia del control CRED, y el olvido de las fechas programadas. Adicionalmente, un 13 % hizo referencia a actitudes negativas hacia el servicio, como el desinterés o la influencia de creencias culturales que obstaculizan la asistencia. Por otra parte, en el ámbito institucional, el 63 % de las investigaciones analizadas reportaron barreras tales como extensos tiempos de espera, demoras en el inicio de la atención, insatisfacción con la calidad del servicio, deficiencia en la información brindada y falta de confianza en el personal de salud. Además, un 21 % señaló la escasa disponibilidad de profesionales en los establecimientos, y un 25 % destacó la dificultad para acceder físicamente a los centros de salud, ya sea por la lejanía o condiciones del entorno. En síntesis, los estudios revisados evidencian una clara relación entre estos factores y la falta de asistencia a los controles CRED, lo que subraya la urgencia de implementar estrategias orientadas a aumentar la cobertura y mejorar el acceso efectivo a dichos servicios preventivos.

Seijas (14) En la ciudad de Lima el año 2020, realizo una investigación que tuvo como Objetivo: “Determinar la deserción del Programa Control de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 3 años del Hospital Santa Isabel - El Porvenir. Trujillo, La Libertad 2017”. La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional de tipo transversal. Como método de recolección de información se empleó la entrevista estructurada, utilizando dos instrumentos: una guía basada en el Carné de Atención Integral del Niño y una guía de entrevista, ambos validados mediante los coeficientes Alfa de Cronbach y Kuder-Richardson. Se llevó a cabo un análisis de los porcentajes de abandono, tanto absoluto como relativo, junto con la identificación de factores asociados, los cuales fueron agrupados en categorías socioeconómicas, culturales y de accesibilidad. Los resultados evidenciaron que la tasa de deserción absoluta fue del 65,2 %, mientras que la deserción relativa representó el 34,8 %. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la edad materna y los tipos de deserción observados. En el ámbito cultural, el nivel educativo de la madre y su vinculación al programa de salud demostraron influir en la continuidad de la asistencia. Por otro lado, no se identificó una relación significativa en lo referente al factor de accesibilidad. En conclusión, la deserción absoluta constituye el porcentaje más elevado (65,2 %), frente a la relativa (34,8 %). Los factores socioeconómicos —como la edad de la madre— y los culturales —incluyendo el nivel educativo y el compromiso con el programa de salud— mantienen una asociación relevante con la inasistencia a los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED).

Cóndor (15) En el año 2020 la ciudad de Piura, realizo una investigación que tuvo como Objetivo: “Describir los determinantes de la salud en niños menores de 5 años del Asentamiento Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018”. Materiales y Métodos: Se trató de un estudio de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo y diseño de casilla única. Para la recolección de información se aplicó un cuestionario a una muestra de 183 participantes. Resultados: El 59 % de los menores evaluados eran niñas, con edades comprendidas entre 1 y 4 años. El 60,1 % de las madres contaba con educación secundaria completa o incompleta. El 37,7 % de las familias tenía ingresos mensuales inferiores a 750 soles y el 57,4 % de las madres se dedicaba a trabajos eventuales. La mayoría residía en viviendas propias, con acceso a servicios básicos como agua potable por red pública, pisos de loseta o cemento, baño privado y asistencia regular a establecimientos de salud.

Además, se reportó que los niños se bañaban diariamente, poseían esquemas de vacunación completos y en más del 50 % de los casos dormían entre 8 y 10 horas. Sin embargo, se identificó que la mayoría de las familias no recibía respaldo institucional ni participaba en redes de apoyo organizado. Conclusiones: Se concluye que las madres presentan un nivel educativo limitado y que las condiciones socioeconómicas de las familias son generalmente desfavorables. El apoyo social con el que cuentan proviene principalmente de su entorno familiar cercano, en coherencia con sus patrones culturales, lo que explica su escasa participación en programas sociales. Estas circunstancias impactan directamente en la salud y los hábitos de vida de los niños.

Antecedentes internacionales

Mphasha et al (16) en el año 2023 desarrollaron en Limpopo Sudáfrica una investigación con el objetivo de “Incumplimiento de las sesiones de seguimiento y promoción del crecimiento entre los cuidadores de niños menores de 5 años en el municipio de Polokwane, provincia de Limpopo”. Metodología: La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando un diseño exploratorio de tipo fenomenológico. Se realizaron entrevistas individuales a 23 personas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. El número de participantes fue determinado con base en el criterio de saturación teórica de la información. Las entrevistas fueron grabadas en formato de audio y los datos obtenidos se analizaron siguiendo la técnica de los ocho pasos propuesta por Tesch, utilizando una codificación de tipo inductiva, descriptiva y abierta. Para asegurar la calidad del estudio, se aplicaron los principios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Los hallazgos revelaron que uno de los principales motivos de inasistencia a las sesiones del programa de Buenas Prácticas de Maternidad (BPM) fue la falta de conocimiento sobre su utilidad, así como deficiencias en la atención brindada por el personal de salud, destacándose los extensos tiempos de espera. Asimismo, la prestación inconsistente de los servicios en los establecimientos y la ausencia de seguimiento a hijos anteriores afectaron la constancia en la participación. También se identificaron barreras económicas y de transporte que dificultaron el acceso.

En conclusión, la escasa asistencia a las sesiones de BPM se encuentra influenciada por el desconocimiento sobre su valor preventivo, la atención inadecuada en los centros de salud y la oferta irregular del servicio. Ante ello, se recomienda a las entidades responsables del sistema sanitario implementar medidas que aseguren la continuidad de las sesiones y promuevan estrategias de sensibilización comunitaria para fortalecer la participación.

Simegn et al (17). En el año 2024 en Ethiopia desarrollaron una investigación con el Objetivo: “Determinar la proporción agrupada de utilización de GMP y sus factores contribuyentes entre niños menores de dos años en Etiopía”. La investigación, inscrita en el registro PROSPERO (CRD42023472746) y llevada a cabo conforme a las directrices establecidas por PRISMA-2020, consistió en un metanálisis basado en siete estudios que involucraron a un total de 4027 participantes. Se recopilaron datos tanto de bases electrónicas como de fuentes no publicadas, empleando un modelo de efectos aleatorios con un intervalo de confianza del 95 %, utilizando el software STATA versión 17. Para evaluar la heterogeneidad entre estudios se aplicó el estadístico I^2 , mientras que la existencia de sesgo en estudios de menor tamaño fue analizada mediante un gráfico de embudo y la prueba de Egger. Los resultados revelaron que la tasa de participación en las sesiones del programa de Buenas Prácticas de Maternidad (BPM) fue del 25,71 %. Se identificaron varios factores asociados a una mayor adherencia, entre ellos el seguimiento durante las etapas prenatal y posnatal, la orientación proporcionada a las madres, el nivel educativo de los padres, el uso de tarjetas de salud familiar y el conocimiento materno acerca del programa. Como conclusión, se destaca que la cobertura de las sesiones BPM en Etiopía permanece baja, y que los factores mencionados desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la participación. En consecuencia, se recomienda el diseño e implementación de políticas basadas en evidencia, así como estrategias específicas que promuevan la asistencia y mejoren la ejecución del programa.

Dagne et al. (18) en el año 2021 desarrollaron una investigación con el Objetivo: “Identificar los determinantes de la utilización de servicios de monitoreo y promoción del crecimiento (GMP) entre niños de 0 a 23 meses de edad en el distrito de Legambo, zona de Wollo Sur, norte de Etiopía, 2020”. La investigación, de tipo caso-control no apareado,

incluyó a 358 madres seleccionadas mediante un muestreo multietápico, alcanzando una tasa de participación del 98,6 %. Para el análisis de los datos se aplicaron modelos de regresión logística, tanto bivariada como multivariada, con el objetivo de identificar los factores determinantes en la utilización de los servicios de monitoreo del desarrollo infantil (BPM). Los hallazgos revelaron que variables como el nivel de conocimiento de las madres, una actitud favorable hacia el servicio, la recepción de consejería específica sobre BPM, la asistencia a controles prenatales, la edad del niño (particularmente entre los 12 y 23 meses) y la cercanía al establecimiento de salud, se asocian de manera significativa con una mayor frecuencia de uso de estos servicios. En síntesis, se concluye que la edad del menor, el grado de conocimiento y actitud de la madre, junto con la atención prenatal y el acceso a orientación nutricional, constituyen factores clave para fomentar la participación en los servicios de seguimiento del crecimiento infantil. En función de estos resultados, se recomienda reforzar las estrategias de consejería alimentaria y facilitar el acceso equitativo a dichos servicios para mejorar su cobertura y eficacia.

Simachew et al (19). En el año 2024 desarrollaron una investigación en Ethiopia que tuvo como Objetivo: “Evaluar la utilización de servicios GMP y los factores asociados entre niños menores de dos años en Etiopía”. Metodología: Se llevó a cabo una revisión sistemática acompañada de un metanálisis centrado en estudios observacionales. Resultados: El análisis incluyó nueve investigaciones que, en conjunto, abarcaron una población total de 4768 participantes. La tasa combinada de uso del servicio de Monitoreo del Crecimiento y Desarrollo (GMP) entre niños menores de dos años en Etiopía fue estimada en 23,21 %, con un intervalo de confianza del 95 % entre 16,02 % y 30,41 %, mostrando una heterogeneidad considerable ($I^2 = 97,27 \%$, $p = 0,0001$). Se identificaron diversos factores significativamente relacionados con la utilización del servicio. Las madres que habían recibido orientación sobre GMP presentaron una mayor probabilidad de acceso (OR = 3,16; IC 95 %: 2,49–4,00). De igual modo, el uso de la tarjeta de salud familiar por parte del padre (OR = 3,29; IC 95 %: 1,49–7,28), la asistencia materna a controles postnatales (OR = 3,93; IC 95 %: 2,40–6,42) y prenatales (OR = 3,15; IC 95 %: 1,29–7,69) fueron factores positivamente asociados con la participación en el servicio de GMP para menores de dos años.

Upadhyay, et al (20). En el año 2024 realizó una investigación en el distrito de Gorkha, Nepal. que tuvo como Objetivos “Evaluar la utilización de servicios GMP y los factores asociados entre niños pequeños en el distrito de Gorkha, Nepal”. La investigación, de tipo transversal, fue realizada en la comunidad de Gorkha entre los meses de abril y junio de 2024, e incluyó la participación de 290 madres junto a sus hijos. La selección de la muestra se efectuó mediante un muestreo aleatorio por etapas, y la recolección de información se llevó a cabo mediante entrevistas estructuradas utilizando cuestionarios previamente diseñados. El procesamiento de los datos incluyó análisis descriptivos y la aplicación de regresión logística multivariada, con el objetivo de determinar los factores asociados a la utilización de los servicios de vigilancia del crecimiento infantil (GMP). Los resultados revelaron que únicamente el 5,5 % de los menores completó las 24 visitas estipuladas, mientras que un 23,8 % asistió a más de 15 controles, ubicándose en el percentil 75 en cuanto al uso del servicio. Se identificó una asociación significativa entre el nivel de conocimiento materno y la frecuencia de asistencia, siendo que las madres con mayor información sobre el programa mostraron una probabilidad notablemente superior de utilizar estos servicios (OR ajustado = 4,23; IC 95 %: 2,070–8,650; $p < 0,001$). Entre las principales dificultades reportadas para acudir a los controles se destacaron la falta de tiempo y las obligaciones domésticas, mencionadas por el 85 % de las participantes.

Seidu, et al (21). En el año 2021 realizaron una investigación en zonas rurales del norte de Ghana con el Objetivos “Evaluar la utilización de servicios GMP y los factores asociados entre pares madre-hijo en el norte rural de Ghana”. La investigación, de tipo transversal analítico, contó con la participación de 400 madres de niños entre 0 y 59 meses, clasificados en tres rangos de edad. Para la recopilación de información, se aplicó un cuestionario semiestructurado que combinó preguntas abiertas y cerradas. Posteriormente, se utilizó análisis de regresión logística multivariante con el fin de identificar los factores que determinan la utilización de los servicios de monitoreo del crecimiento infantil (GMP). Los hallazgos indican que el 28,5 % de las madres hacía uso de estos servicios. A pesar de que el 60 % conocía la edad adecuada para acceder al programa, únicamente el 9 % fue capaz de interpretar correctamente las gráficas de crecimiento en el registro de salud infantil. Se evidenció que las madres de niños entre 0 y 11 meses presentaban una

probabilidad 3,9 veces mayor de asistir a GMP en comparación con aquellas con hijos mayores ($p = 0,009$). Por otro lado, las madres con menor nivel de conocimiento mostraron 2,19 veces más probabilidades de utilizar estos servicios en contraste con las que poseían mayor información ($p = 0,003$). En conclusión, tanto la edad del menor como el grado de conocimiento de la madre se relacionan de manera significativa con el uso del monitoreo del crecimiento infantil. Estos resultados subrayan la necesidad de implementar estrategias educativas que fortalezcan la comprensión materna sobre la importancia y funcionalidad del programa GMP.

Girma, et al (22). En el año 2023 realizaron un estudio En el distrito de Digelu Tijo, en el centro-sur de Etiopía. que tuvo como Objetivo “Analizar la utilización de los servicios de seguimiento y promoción del crecimiento y los factores asociados en niños menores de dos años en el distrito de Digelu Tijo, ubicado en la zona centro-sur de Etiopía”. La investigación, de tipo transversal, fue llevada a cabo en zonas rurales del distrito de Digelu Tijo, Etiopía, con el propósito de evaluar la utilización de los servicios de monitoreo y promoción del crecimiento (GMP) en niños menores de dos años, así como los factores que influyen en dicha asistencia. Para identificar asociaciones significativas, se aplicó un modelo de regresión logística multivariada, considerando un nivel de significancia estadística de $p < 0,05$. Los resultados revelaron que el 32,8 % de los menores accedía a los servicios de GMP. Entre los factores que presentaron una asociación significativa con su uso se encuentran: la edad del niño entre 0 y 11 meses (AOR = 3,59), el uso de la tarjeta de salud familiar (AOR = 2,65), haber recibido atención posnatal (AOR = 1,54), acudir exclusivamente a servicios de GMP (AOR = 2,23), y la comunicación entre padres sobre el crecimiento infantil (AOR = 3,29). En conclusión, la baja cobertura de los servicios de GMP se relaciona con múltiples factores individuales y familiares. Por ello, se recomienda implementar estrategias que promuevan la participación activa del padre y fortalezcan el diálogo en el entorno familiar, a fin de mejorar la asistencia y continuidad en el monitoreo del crecimiento infantil.

9.2. Bases teóricas:

Variable Independiente: Factores asociados

Conceptualización de la variable:

La variable "factores asociados" hace referencia a las condiciones o características que pueden tener una relación causal o estadística con un determinado fenómeno, como lo es en este caso el no seguimiento adecuado del control de crecimiento y desarrollo por parte de las madres de niños menores de cinco años. En el ámbito de la epidemiología, estos factores son considerados variables independientes que pueden afectar, ya sea de forma favorable o desfavorable, los comportamientos relacionados con la salud (23). Según la Organización Mundial de la Salud, los factores asociados al incumplimiento de controles de salud pueden clasificarse en determinantes estructurales, como el nivel educativo, situación socioeconómica y el acceso a servicios; y determinantes intermedios, como el ambiente familiar, el apoyo social y las condiciones laborales, los cuales tienen una influencia directa sobre las decisiones en salud tomadas por las madres (24).

Clasificación de los factores asociados

a. Factores Económicos y Sociales: Diversas investigaciones señalan que las dificultades económicas en muchas familias representan una barrera para acudir a los controles de salud, especialmente cuando las madres tienen jornadas laborales extensas o no disponen de los medios necesarios para cubrir gastos adicionales, como el transporte o el cuidado de otros hijos. Asimismo, la carencia de movilidad, los horarios laborales inflexibles y los gastos relacionados, como el pago por consultas o medicamentos, influyen negativamente. La participación del padre u otros familiares puede contribuir a que se realicen estas visitas, mientras que la ausencia de apoyo familiar dificulta que se les dé prioridad (25).

b. Factores e Influencias Culturales: Las prácticas culturales y las tradiciones familiares influyen en la disposición de las madres para acudir a los controles médicos. La manera en que se entiende la salud y lo que se considera un desarrollo adecuado del niño puede diferir según el contexto social y cultural al que pertenezcan (27). La percepción

tradicional sobre el cuidado infantil, junto con la inclinación hacia métodos de medicina alternativa, puede reducir el interés en acudir a controles periódicos, sobre todo cuando no se observan señales evidentes de enfermedad (28).

e. Acceso a Servicios de Salud/ institucionales: Las vivencias previas, como la forma en que fueron atendidas o la valoración que se le dio a las consultas, pueden impactar de manera favorable o desfavorable en la continuidad de los controles infantiles. La cercanía y accesibilidad a los servicios de salud son factores determinantes. Las familias que viven en zonas rurales suelen enfrentar más dificultades debido a la distancia y limitaciones geográficas para recibir atención médica oportuna (29).

9.2.1.2. Teorías de la variable

Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) Según el modelo planteado por Ajzen en 1991, la intención de llevar a cabo una acción, como asistir al control CRED, se basa en tres elementos clave: la actitud que se tiene frente a dicha acción, la influencia de las normas sociales percibidas (es decir, la presión social) y la percepción sobre la capacidad personal para realizarla (facilidad o dificultad). Desde esta perspectiva, los factores que influyen en la adherencia a los controles pueden interpretarse como elementos que afectan estos tres aspectos (30).

El Modelo de Creencias en Salud (HBM) La teoría desarrollada por Rosenstock en 1974 explora cómo las percepciones personales influyen en las decisiones relacionadas con la salud, tomando en cuenta la percepción del riesgo, los beneficios esperados y los obstáculos percibidos para la prevención. En el ámbito del control pediátrico, muchas madres tienden a restarle importancia a estas visitas médicas debido a que no se sienten expuestas o no consideran grave la posible situación. Factores como las dificultades económicas, la lejanía de los centros de salud y las creencias culturales limitan el acceso a los controles. Además, la idea de que estos no repercuten significativamente en la salud del niño, la falta de motivación y la escasa confianza en su capacidad para manejar la situación contribuyen a una baja adherencia. Esta teoría ha sido fundamental para entender la conducta en salud materno-infantil y diseñar estrategias que promuevan una mayor implicación en la atención preventiva (31).

Finalmente, La **Teoría de la Autoeficacia (Self-Efficacy Theory)**: Desde el enfoque de la Teoría Social Cognitiva de Bandura, se destaca el papel fundamental de la creencia en la propia capacidad para llevar a cabo una acción. Cuando la autoeficacia es baja, se vuelve más difícil mantener la asistencia a los controles, especialmente en contextos donde existen obstáculos sociales y económicos. Estas teorías, al integrarse, ofrecen una visión amplia sobre los factores que influyen en la conducta de las madres respecto al control CRED, y sirven como base para desarrollar estrategias que fomenten una mayor adherencia (32).

9.2.1.3. Evolución histórica de la variable

La comprensión de los elementos que afectan las conductas vinculadas a la salud, como la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED), ha evolucionado significativamente, alineándose con los progresos en las teorías del comportamiento humano y la salud pública. Durante las décadas de 1950 y 1960, predominaba un enfoque biomédico que ponía énfasis en lo clínico y lo individual, partiendo del supuesto de que ofrecer servicios era suficiente para asegurar su utilización. No obstante, la escasa participación observada incluso en entornos con acceso a dichos servicios llevó a cuestionar esta perspectiva e impulsó la consideración de factores más amplios y complejos (33).

Desde los años 70, se empezaron a integrar enfoques como el Modelo de Creencias en Salud y la Teoría de la Acción Razonada, los cuales introdujeron factores como las percepciones personales, la presión social y la evaluación de las consecuencias esperadas de una acción. Este cambio de perspectiva permitió entender que las decisiones relacionadas con la salud no solo dependen de aspectos médicos, sino también de factores psicológicos y culturales (34). En las décadas de 1980 y 1990, se desarrollaron modelos integradores como la Teoría del Comportamiento Planificado y el enfoque PRECEDE-PROCEED, que organizaron los factores influyentes en tres categorías: predisponentes (como conocimientos y creencias), facilitadores (relacionados con los recursos disponibles y el acceso a servicios) y reforzadores (como el respaldo social). Estos

enfoques permitieron ampliar la comprensión del comportamiento en salud, incorporando dimensiones comunitarias e institucionales al análisis (35).

En la actualidad, el enfoque socio ecológico se ha fortalecido como una visión integral que considera la interacción entre factores personales, familiares, comunitarios y estructurales en el comportamiento relacionado con la salud. Esta aproximación ha resultado clave para comprender las razones del incumplimiento del control CRED, especialmente en escenarios donde influyen aspectos como el nivel educativo de la madre y las medidas adoptadas a nivel de políticas públicas (36). En resumen, los estudios recientes destacan que elementos estructurales como la situación económica, el rol de género, las inequidades sociales y la localización geográfica influyen de manera decisiva. Esto demuestra que el no cumplimiento de los controles no se debe únicamente a elecciones personales, sino también a contextos sociales complejos que demandan respuestas integrales desde múltiples sectores.

9.2.1.4. Otros aspectos relevantes de la variable

Los distintos factores relacionados pueden afectar el fenómeno analizado de múltiples formas. Entre los elementos más relevantes se encuentran los siguientes:

1. **Interacción entre factores:** Los aspectos socioeconómicos pueden vincularse con elementos culturales y del entorno, influyendo en la manera en que las personas acceden a los servicios de salud. La interacción de varios factores puede producir un efecto acumulativo que intensifique su influencia sobre el fenómeno analizado (37).
2. **Variabilidad según el contexto:** Los factores relacionados pueden variar según el contexto geográfico, social y económico. En investigaciones de salud pública, estos elementos suelen presentar diferencias entre comunidades urbanas y rurales (38).
3. **Influencia en la toma de decisiones:** La manera en que una persona percibe el riesgo y su nivel de confianza en los servicios de salud puede afectar su compromiso con los tratamientos o controles médicos. La formación educativa y la disponibilidad de información también pueden transformar la respuesta individual frente a los factores implicados (39).

9.2.1.5. Dimensión de la variable 1: Factores asociados

a. Dimensión 1: Factores socioeconómicos:

Las condiciones económicas y laborales de una persona influyen de manera significativa en su capacidad para acceder y utilizar los servicios de salud. En el caso de las madres, estos aspectos pueden determinar su asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED), ya que inciden en la disponibilidad de tiempo, la estabilidad financiera y el apoyo dentro del hogar. En consecuencia, cuando existen limitaciones socioeconómicas, suelen presentarse mayores obstáculos para cumplir con las evaluaciones preventivas y para recibir una atención de salud continua y de calidad (40).

Indicadores:

Condición laboral: La situación económica y las condiciones laborales de cada individuo inciden directamente en sus posibilidades de acceder y hacer uso de los servicios de salud. En el caso de las madres, estos factores pueden condicionar su participación en los controles de crecimiento y desarrollo (CRED), pues afectan el tiempo disponible, la estabilidad en los ingresos y el respaldo familiar. Por ello, cuando se presentan carencias socioeconómicas, se incrementan las dificultades para asistir a las evaluaciones preventivas y para garantizar una atención sanitaria constante y adecuada (41).

Actividades del hogar: Las labores domésticas y el cuidado de los hijos demandan una considerable inversión de tiempo, lo que puede restringir la posibilidad de acudir a los establecimientos de salud. La acumulación de responsabilidades dentro del hogar se convierte en un elemento que influye en la atención de las necesidades de salud de los niños, particularmente en ausencia de una red familiar o social que brinde apoyo (42).

Gastos que representan al acudir al control: Este indicador considera tanto los gastos directos como los indirectos asociados a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo, tales como el transporte, la alimentación o la reducción de ingresos por ausentarse del trabajo. Estos costos pueden representar una limitación económica que dificulte la asistencia constante de las madres a los servicios CRED (43).

a. Dimensión 2: Factores culturales:

Los factores culturales engloban las creencias, valores, tradiciones y saberes que condicionan la forma en que las personas perciben y actúan frente a su salud. En relación con el control de crecimiento y desarrollo (CRED), estos elementos influyen en cómo las madres valoran el seguimiento del desarrollo de sus hijos, interpretan las acciones preventivas y toman la decisión de asistir o no a los servicios de atención infantil (44).

Indicadores:

Conocimiento sobre el control de CRED: El conocimiento acerca del control de crecimiento y desarrollo (CRED) hace referencia al nivel de comprensión que posee la madre o cuidadora respecto a los propósitos, frecuencia, ventajas y actividades que conforman dicho programa. Esta comprensión le facilita valorar la relevancia de acudir con su hijo a las citas establecidas y involucrarse activamente en el monitoreo de su desarrollo y crecimiento (45).

Importancia sobre el control de CRED: Hace alusión al valor que la madre otorga al programa de control de crecimiento y desarrollo (CRED) como una acción fundamental para prevenir enfermedades, detectar de forma temprana posibles alteraciones en la salud infantil y promover el desarrollo integral del niño. Por ejemplo, se reconoce que asistir a los controles permite identificar casos de anemia, retraso en talla o desarrollo y adoptar medidas oportunas para su abordaje (46).

Frecuencia de controles CRED: Se refiere al nivel de cumplimiento que la madre o cuidadora mantiene respecto al calendario de controles periódicos definidos por el programa CRED, de acuerdo con la edad del niño. Abarca la asistencia dentro de los intervalos establecidos para el seguimiento del crecimiento, el desarrollo y las evaluaciones de salud (47).

Creencia para la asistencia al control de CRED: Incluye las creencias, actitudes, percepciones y normas culturales que la madre mantiene en relación con el control CRED, como la idea de que “solo se debe acudir al establecimiento de salud cuando el niño presenta alguna enfermedad” o que el control no es necesario si aparenta estar sano. Este tipo de percepciones pueden favorecer o dificultar la asistencia constante a los controles (48).

b. Dimensión 3: Factores institucionales:

Los factores institucionales comprenden los elementos organizativos, de infraestructura y de gestión del sistema de salud que influyen en la calidad, accesibilidad y oportunidad del servicio. En el caso del control de crecimiento y desarrollo (CRED), estos factores abarcan aspectos como el horario disponible, el tiempo de espera, la atención brindada por el personal y la cercanía del establecimiento. Cada uno de estos componentes impacta en la satisfacción de las usuarias y en su constancia en los controles programados. Cuando las condiciones institucionales son desfavorables como horarios restringidos, largas demoras o un trato poco cordial se incrementa la posibilidad de inasistencia o abandono del seguimiento del CRED. (49).

Indicadores:

Horario de atención: Hace alusión a los horarios en los que el centro de salud está habilitado para brindar atención. Cuando estos no se ajustan a las necesidades de las usuarias o son limitados, pueden representar una barrera para que las madres lleven a sus hijos a los controles, sobre todo si tienen empleo u otras obligaciones. Se refiere al rango de horas en que el centro de salud está disponible para brindar atención a los usuarios. Un horario rígido, poco compatible con las responsabilidades del paciente (trabajo, hogar, desplazamiento) puede reducir la utilización del servicio (50).

Tiempo de espera para ser atendido: Tiempo que transcurre desde que el paciente llega al establecimiento de salud hasta que inicia la atención por el personal sanitario. El tiempo de espera prolongado se asocia con menor satisfacción, mayor abandono y menor uso del servicio (51).

Tiempo de atención: Duración efectiva de la consulta o del servicio brindado al paciente desde el inicio de la atención hasta que finaliza el encuentro clínico. Un tiempo de atención insuficiente puede comprometer la calidad de la atención, la comunicación y el cumplimiento de recomendaciones (52).

Trato del personal: Calidad de la interacción interpersonal entre el personal de salud y los usuarios, incluyendo amabilidad, respeto, claridad en la comunicación, empatía y profesionalismo. Un trato deficiente puede desincentivar la asistencia y provocar abandono del servicio (53).

Distancia al centro de salud: Medida física o geográfica que separa el domicilio del usuario del establecimiento de salud. Una mayor distancia puede implicar barreras de acceso (tiempo de desplazamiento, costo de transporte, dificultad para llegar), lo que reduce la utilización del servicio (54).

9.2.1.6. Teoría de enfermería referente a la variable 1:

Teoría de la Enfermería de Orem (Modelo de Autocuidado)

Esta teoría plantea que los individuos poseen tanto la responsabilidad como la habilidad de cuidar su propia salud y la de quienes dependen de ellos. Resalta el valor del autocuidado y el papel del personal de enfermería en facilitar que las personas logren un bienestar adecuado; Aplicación en el contexto: Las enfermeras pueden identificar el nivel de autonomía en el cuidado que tienen las madres y ofrecer orientación y acompañamiento para fortalecer su capacidad de asistir a los controles y atender adecuadamente la salud de sus hijos (55).

Teoría de la Adaptación de Roy

La Teoría de la Adaptación de Roy aborda cómo las personas responden y se ajustan ante diversos cambios y situaciones estresantes a lo largo de su vida. Esta perspectiva permite analizar los elementos que afectan la habilidad de las madres para enfrentar los desafíos de la maternidad y cumplir con las exigencias del cuidado en salud. Aplicación en el contexto: Desde la enfermería, se puede brindar apoyo a las madres para enfrentar el estrés

relacionado con la crianza, como el cuidado de un bebé, y proporcionarles herramientas que faciliten su participación en los controles médicos. (56).

9.2.2. Variable 2: Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo (CRED)

9.2.2.1. Conceptualización de la variable

El incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo (CRED) se define como la inasistencia total o parcial del padre, madre o cuidador a las citas programadas conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Salud del Perú, según lo dispuesto en la Norma Técnica N.º 238-MINSA/DGIESP-2025. (57). El control de crecimiento y desarrollo (CRED) es una estrategia preventiva fundamental orientada a supervisar el desarrollo integral del niño y a identificar de manera temprana posibles alteraciones o riesgos en su salud. La falta de asistencia a estos controles reduce las posibilidades de detección oportuna y atención adecuada. Se considera incumplimiento cuando el menor no asiste a uno o más controles en el tiempo previsto, interrumpe el seguimiento por más de dos meses consecutivos o no completa las evaluaciones anuales establecidas según su grupo etario (59).

9.2.2.2. Teorías de la variable:

Modelo de Creencias en Salud (Health Belief Model): Este enfoque sostiene que las decisiones en torno al cuidado de la salud dependen de cómo las personas interpretan ciertos factores, como la probabilidad de que sus hijos presenten problemas médicos (percepción de vulnerabilidad), la seriedad de las posibles consecuencias si no se actúa a tiempo, los beneficios percibidos de asistir a los controles y los obstáculos que pueden interferir, como el costo o la falta de tiempo. Desde la práctica de enfermería, este modelo puede ser útil para identificar creencias erróneas en los cuidadores y reforzar la relevancia del seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil, favoreciendo una mayor asistencia a estos servicios (60).

El Modelo Socio ecológico: Plantea que las conductas relacionadas con la salud, como acudir a los controles de crecimiento y desarrollo, están condicionadas por múltiples niveles de influencia. En el plano individual, influyen aspectos como el conocimiento, las

creencias y las capacidades personales. En el nivel relacional, el respaldo de la familia y las redes de apoyo social influyen en las decisiones. A nivel comunitario, factores como la presencia de recursos y la facilidad de acceso a los servicios sanitarios afectan la participación. Por último, en el contexto social y político, las políticas de salud y las normas culturales establecen el marco que posibilita o limita la atención. Esta perspectiva ayuda al personal de salud a entender mejor el entorno de las madres y a diseñar estrategias más eficaces que fomenten la asistencia continua al control infantil (61).

9.2.2.3. Evolución de la variable:

En las primeras décadas del siglo XX, las intervenciones dirigidas a la salud infantil estuvieron orientadas principalmente a disminuir las muertes causadas por enfermedades infecciosas. Para ello, se priorizó la educación en prácticas de higiene y se desarrollaron campañas de inmunización con el fin de evitar la propagación de estas enfermedades (62). Entre los años 60 y 80, el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil adquirió relevancia dentro de la pediatría, convirtiéndose en una estrategia clave no solo para evitar enfermedades, sino también para fomentar el desarrollo global del niño. Durante ese tiempo, las investigaciones comenzaron a resaltar la necesidad de llevar a cabo revisiones periódicas que contemplaran aspectos físicos, nutricionales, cognitivos y educativos (63).

Durante los siglos XX y XXI, el crecimiento urbano y el aumento de la migración hacia las ciudades han impactado el acceso a la atención médica, especialmente en países en desarrollo como el Perú, donde las brechas entre zonas urbanas y rurales aún persisten (64). En áreas rurales, las familias suelen tener más obstáculos para acudir a los controles de salud infantil, principalmente por la lejanía de los centros de atención y los costos asociados al transporte. Como respuesta a esta problemática, a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, diversas naciones, incluido el Perú, adoptaron políticas como la Atención Integral de Salud Infantil, orientadas a ampliar el acceso y fortalecer la calidad del servicio brindado (65).

En los últimos años, se ha fortalecido la difusión de campañas informativas orientadas a los padres, con el objetivo de enfatizar la importancia del seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil. Estas iniciativas han contribuido significativamente a transformar

percepciones y disminuir la falta de asistencia. Asimismo, la disponibilidad de información a través de plataformas digitales y redes sociales ha incrementado el conocimiento sobre el cuidado infantil, incentivando una participación más constante en los controles de salud (66). Estudios actuales realizados en Perú evidencian que la falta de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo continúa siendo un problema relevante. Según información recogida por la ENDES, factores como el nivel educativo de los padres, la situación económica y la zona geográfica de residencia tienen un impacto directo en la participación en dichos controles (67).

Aún se mantienen barreras de tipo económico, cultural y relacionadas con el acceso, que limitan la participación en los controles de salud. Investigaciones indican que las madres con menor formación académica y escasos recursos económicos tienden a ausentarse con mayor frecuencia. Ante este panorama, se promueve la implementación de enfoques integrales que aborden no solo la salud física, sino también el contexto emocional y social de las familias (68). Las iniciativas que promueven la implicación de la comunidad y refuerzan la participación activa de los padres han demostrado ser efectivas para incrementar la asistencia. Asimismo, la incorporación de tecnologías móviles, como los recordatorios por mensaje y los recursos informativos digitales, se presenta como una alternativa eficiente para favorecer el cumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo (69).

9.2.2.4. Otros aspectos relevantes de la variable:

El seguimiento del crecimiento y desarrollo consiste en revisiones periódicas que permiten observar el estado físico, emocional y psicomotor de los niños. Estas evaluaciones son clave para detectar a tiempo problemas como desnutrición, retrasos en el desarrollo o enfermedades. De acuerdo con la ENDES 2021, aproximadamente el 40% de los niños menores de un año no completa el control establecido. La situación es más crítica en zonas rurales, donde solo el 30% accede a estos servicios, en comparación con un 65% en áreas urbanas. Sin embargo, incluso en contextos urbanos persisten desigualdades, sobre todo en familias en situación de vulnerabilidad (70).

9.2.2.5. Dimensiones de la variable 2: incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo.

a. Dimensión 1: Frecuencia de la asistencia a los controles CRED

La frecuencia de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) hace referencia a cuántas veces los niños menores de cinco años participan en las evaluaciones programadas dentro de los periodos establecidos por el Ministerio de Salud, de acuerdo con su grupo de edad. Este indicador muestra la regularidad y compromiso de la madre o cuidador en el acompañamiento del desarrollo infantil, siendo un factor esencial para evaluar el grado de cumplimiento del programa de salud del niño (57,58).

Controles asistidos según edad: Se refiere al número de controles de crecimiento y desarrollo (CRED) a los que asiste el niño o niña según su edad y el cronograma fijado por el Ministerio de Salud. Este indicador permite verificar si las evaluaciones se realizan conforme a la periodicidad recomendada: una vez al mes durante el primer año, cada dos meses entre uno y dos años, cada tres meses entre los dos y cuatro años, y cada seis meses desde los cuatro años en adelante (58).

Intervalo entre controles: Se refiere al tiempo que pasa entre un control CRED y el siguiente, tomando en cuenta la frecuencia indicada por la norma técnica. Conservar un intervalo adecuado permite un seguimiento continuo del crecimiento y desarrollo infantil. Si el tiempo entre controles excede lo establecido, puede reflejar demoras o interrupciones en la atención, mientras que los intervalos regulares evidencian un cumplimiento correcto del programa. Este indicador es fundamental para valorar la oportunidad y la constancia del monitoreo (71).

Abandono de controles CRED: Este indicador mide la inasistencia del niño o niña a los controles CRED durante un periodo igual o superior a dos meses consecutivos. De acuerdo con la Norma Técnica N.º 238-MINSA/DGIESP-2025, esta situación se considera un incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo. La ausencia prolongada interrumpe la detección oportuna de riesgos y limita las acciones de prevención y promoción en la salud infantil (72).

9.2.2.6. Teoría de enfermería referente a la variable 2:

1. Teoría de las Necesidades de Virginia Henderson

La teoría propuesta por Virginia Henderson se centra en la atención de las necesidades humanas esenciales como pilar para mantener y mejorar la salud. Desde este enfoque, el rol de la enfermera es fundamental, ya que apoya al paciente en la realización de actividades que favorecen su recuperación y bienestar. Henderson identificó 14 necesidades básicas, que van desde funciones fisiológicas hasta dimensiones del bienestar integral. En el contexto del incumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo, esta teoría resulta pertinente al evidenciar que la falta de asistencia podría reflejar un descuido en el cumplimiento de las necesidades esenciales del niño. A través de esta mirada, el personal de enfermería puede detectar dichas deficiencias y trabajar con las madres para fortalecer su comprensión y compromiso con el cuidado infantil (73)

2. Modelo de Adaptación de Roy

El Modelo de Adaptación desarrollado por Sister Callista Roy plantea que los individuos funcionan como sistemas que responden de forma constante a los cambios del entorno. Esta teoría sostiene que la salud se mantiene cuando la persona logra adaptarse eficazmente a diferentes desafíos, ya sean físicos, emocionales o sociales. En el caso del incumplimiento de los controles médicos infantiles, el modelo resulta aplicable, ya que reconoce que las madres pueden verse afectadas por diversas fuentes de tensión, como limitaciones económicas, escaso respaldo familiar o influencias culturales, que dificultan su asistencia. Desde este enfoque, el profesional de enfermería puede identificar estos factores y brindar apoyo para fortalecer la capacidad de adaptación de las madres, promoviendo así una mayor continuidad en los controles de crecimiento y desarrollo (74).

3. Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson

La Teoría del Cuidado Humano propuesta por Jean Watson resalta el valor de la conexión emocional entre el profesional de enfermería y el usuario, considerando el cuidado como un componente fundamental para lograr bienestar y una mejor salud. Esta perspectiva plantea que una relación basada en la empatía y la confianza genera un entorno favorable

para la atención. En relación con la falta de cumplimiento en los controles de crecimiento y desarrollo, este modelo enfatiza la importancia de que la enfermera cree un vínculo comprensivo y cercano con las madres. A través de un enfoque que considere los aspectos emocionales y sociales, se puede incrementar el compromiso materno y mejorar la asistencia continua a los servicios de salud infantil (75).

9.3. Definiciones:

Asociados: Se refiere a elementos, personas o entidades que están vinculadas entre sí por una relación, característica o propósito común.

Atención: Intervención deliberada orientada a responder de manera efectiva a necesidades específicas de individuos o grupos, ya sea en contextos de salud, educación o asistencia social, y que implica un enfoque profesional, ético y contextualizado.

Barreras: Condiciones estructurales, culturales o contextuales que restringen o impiden la participación plena o el acceso equitativo a recursos, oportunidades o servicios, limitando el desarrollo individual o colectivo.

Control de crecimiento y desarrollo: Conjunto de evaluaciones periódicas realizadas en niños menores de cinco años para monitorear su desarrollo físico, nutricional y psicomotor.

Cuidados: Prácticas intencionadas dirigidas a preservar la integridad física, emocional y social de los individuos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, en las que se requiere acompañamiento profesional o comunitario para garantizar condiciones dignas de vida.

Culturales: Valores, creencias, costumbres y prácticas que caracterizan a una sociedad o grupo, influyendo en la percepción del mundo y la toma de decisiones.

Económicas: Dimensión vinculada con los factores financieros y materiales que influyen en la organización y funcionamiento de las actividades humanas, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad de bienes, recursos y capacidades de intercambio.

Factores: Elementos, condiciones o circunstancias que influyen directa o indirectamente en un fenómeno, situación o resultado.

Horarios: Organización formal del tiempo que establece la distribución y secuencia de actividades dentro de un marco temporal definido, con el objetivo de optimizar procesos y garantizar el cumplimiento de metas o responsabilidades.

Inclusión: Estrategia y principio orientado a garantizar la participación activa de todos los miembros de una comunidad, con especial énfasis en aquellos grupos históricamente marginados, asegurando igualdad de condiciones y eliminación de discriminación estructural.

Inasistencia: Fenómeno caracterizado por la ausencia recurrente o esporádica de una persona en espacios institucionales o actividades previamente estipuladas, lo cual puede estar asociado a factores personales, sociales o estructurales.

Incumplimiento: Falta de asistencia a controles médicos, omisión de tratamientos prescritos o inobservancia de recomendaciones sanitarias.

Institucionales: Estructuras, normas y políticas establecidas por organizaciones gubernamentales que regulan el funcionamiento social, incluyendo acceso a servicios públicos y programas de salud.

Madres: Mujeres que han concebido y dado a luz a uno o más hijos, asumiendo un rol fundamental en su cuidado, protección y educación.

Niños menores de 5 años: Etapa comprendida entre el nacimiento y los 59 meses de vida, caracterizada por un crecimiento acelerado y un desarrollo intensivo en aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales.

Población: Conjunto definido de individuos que comparten características comunes y que son objeto de estudio o intervención en un espacio determinado, ya sea geográfico, social o institucional.

Seguimiento del crecimiento y desarrollo: Proceso sistemático y continuo que permite evaluar el estado de salud, nutrición y maduración física, cognitiva, emocional y social de los niños desde el nacimiento hasta los cinco años.

Selección: Procedimiento mediante el cual se determina, con base en criterios establecidos, la elección de ciertos elementos o sujetos sobre otros, en función de su adecuación a los objetivos de una investigación, intervención o política pública.

Socioeconómico: Interacción entre factores sociales y económicos que influyen en la calidad de vida, incluyendo ingresos, empleo, educación y acceso a servicios básicos.

Teoría: Conjunto de proposiciones abstractas interrelacionadas que buscan ofrecer una explicación sistemática de fenómenos observados, proporcionando marcos interpretativos para comprender la realidad en contextos científicos o disciplinares.

10. Metodología

El método hipotético-deductivo es un proceso lógico que parte de una teoría general o de conocimientos previos para formular hipótesis, las cuales luego se someten a prueba mediante la recolección y análisis de datos empíricos con el fin de confirmar o refutar dichas hipótesis (76).

10.1. Enfoque de investigación:

El enfoque cuantitativo permite recolectar y analizar datos de forma numérica y objetiva. Se orienta a la medición de variables y al uso del análisis estadístico para validar hipótesis. En este estudio se medirá la relación entre los factores asociados y el incumplimiento del Crecimiento y desarrollo (77).

10.2. Tipo de estudio:

Este estudio es de tipo aplicado, ya que busca aportar soluciones prácticas a un problema real en el ámbito de salud pública. Hernández de Canales define este tipo de investigación como aquella dirigida a aplicar el conocimiento adquirido para resolver necesidades específicas en contextos particulares (78).

10.3. Diseño de investigación:

Un diseño no experimental y de corte transversal se caracteriza por la ausencia de manipulación de variables, con una recolección de datos en un único periodo temporal. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque se fundamenta en la observación de los fenómenos en su entorno original, sin intervención directa del investigador, lo que permite examinar la frecuencia y la relación entre distintas variables en un momento específico (79).

10.4. Población y criterios de selección:

Este estudio tiene como población a 106 madres de niños menores de 1 año que reciben atención en el Centro de Salud Mirones de Lima. La selección de esta población tiene como objetivo identificar los factores que inciden en el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en este grupo específico. Para asegurar que las participantes sean aptas para responder a los objetivos del estudio y que los resultados sean válidos y representativos, se establecerán criterios de inclusión y exclusión adecuados para la muestra.

Criterios de inclusión

- Madres mayores de 18 años y que asisten al Centro de Salud como posta adscrita para su atención.
- Madres que acepten formar parte del estudio y hayan firmado de manera voluntaria su consentimiento informado
- Ausencia de discapacidades mentales o físicas que interfieran con la participación.
- Madres de niños menores de 1 año, pero mayores a los 28 días de nacido.

Criterios de exclusión

- Madres de niños mayores de 1 año, y menores de 28 días de nacido.
- Madres que no han iniciado los controles de CRED.
- Madres que no hablen el idioma principal del estudio.

- Madres con hijos que tengan condiciones médicas que no requieran controles de CRED.
- Madres que no den su consentimiento informado.

10.5. Muestra y muestreo:

MUESTRA:

Para determinar el tamaño de muestra de este estudio descriptivo correlacional de corte transversal, se utilizará la fórmula para poblaciones finitas, dado que la población total está compuesta por 106 madres que asisten al centro de salud en el periodo de 9 meses en el año 2025.

CALCULO DE MUESTRA

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{E^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

N: 106 madres

Z: 1.96 Nivel de confianza de 95%

P: 0.5 probabilidad de éxito

q: 0.5 probabilidad de fracaso (1-p)

E: 0.05 Margen de error permitido.

Por lo tanto, el tamaño de muestra corresponde a 83 madres.

N: Tamaño de la población

Por tanto, el tamaño de muestra corresponde a 83 madres.

MUESTREO:

Se adoptará un diseño de muestreo aleatorio simple ya que es un procedimiento dentro del enfoque probabilístico en el que todos los integrantes de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados (87). La muestra se elige al azar a partir del total de la población, garantizando la imparcialidad en la selección y representatividad de los resultados, asegurando que todas las madres que reúnan los requisitos definidos cuenten con igual oportunidad de ser elegidas como participantes.

El procedimiento constará de los siguientes pasos:

En una primera etapa, se elaborará un listado con la información de 106 madres de niños menores de un año que acuden con frecuencia al centro de salud. Luego, se aplicará un cuestionario con respuestas dicotómicas y se seleccionará al azar a 83 participantes, utilizando una tabla de números aleatorios o un programa informático que garantice objetividad en la elección. Si alguna madre decide no participar o no está disponible, se sustituirá por otra seleccionada aleatoriamente del mismo registro inicial. Este procedimiento permite obtener una muestra representativa y confiable, asegurando que los resultados reflejen fielmente la situación de las madres atendidas en dicho establecimiento.

10.6. Variables:**Variable independiente:**

factores asociados: Los factores asociados son condiciones individuales, sociales, económicas y del sistema de salud que afectan positiva o negativamente la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año (23).

Variable dependiente:

Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo: Hace referencia a la inasistencia de madres o cuidadores a los controles de CRED y al incumplimiento del seguimiento de las recomendaciones (57).

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACION AL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION	ESCALA VALORATIVA
V1 Factores asociados al incumplimiento	comprenden aspectos personales, sociales, económicos y del entorno sanitario que pueden influir, de manera favorable o desfavorable, en la participación en los controles de crecimiento y desarrollo de los niños menores de un año (23).	Para definir la variable se utilizará un instrumento estructurado de 27 ítems con respuestas dicotómicas distribuidos en 3 dimensiones.	Factores socioeconómicos.	- Condición laboral. - Horario laboral. - Actividades del hogar. - Responsabilidad y cuidado dentro del hogar. - Gastos que representan al acudir al control. - Apoyo familiar.	Ordinal	Bajo 0-8 Moderado 9-17 Alto 18-27
			Factores culturales.	- creencias culturales. - creencias familiares. - creencias en la comunidad. - mitos. - tradiciones/creencias religiosas. - importancia de CRED		
			Factores Institucionales.	- Horario de atención. - Tiempo de espera para ser atendido. - Tiempo de atención. - Trato del personal. - Distancia al centro de salud - Información recibida, pertinente y clara. - Personal profesional de enfermería disponible para la atención de CRED. - Infraestructura.		
V2 Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo (CRED).	Hace referencia a la inasistencia de madres o cuidadores a los controles de CRED y al incumplimiento del seguimiento de las recomendaciones (57).	El incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo es un Indicador que evidencia el incumplimiento de la madre al control de CRED.	Esquema oficial de controles cred según norma NTS 238	1° control 2° control 3° control 4° control 5° control 6° control 7° control	ordinal	Cumplimiento (controles completados según la edad cronológica) 1 punto. Incumplimiento 0

10.7. Procedimientos y técnicas:

10.7.1. Técnica

Para la recolección de información se optará por la aplicación de una encuesta, y la observación, debido a su utilidad en la obtención de datos cuantificables y en la comparación sistemática de respuestas.

10.7.2. Descripción de instrumentos

La aplicación del cuestionario se realizará de manera presencial en un espacio reservado y adecuado dentro del centro de salud, previamente, se informará a las participantes sobre los objetivos del estudio y se solicitará su consentimiento informado, luego de la recolección, la información será registrada y codificada en una base de datos para su análisis con el programa IBM SPSS Statistics, garantizando la confidencialidad de todos los datos obtenidos.

Instrumento 1: Cuestionario de Factores Asociados al Incumplimiento

El instrumento fue elaborado a partir del cuestionario diseñado originalmente por Chahuas Rodríguez Eulalia en su investigación titulada “Factores de incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de 1 año en un establecimiento de salud público de Lima, 2017” (59), debido a que dicho instrumento cuenta con más de cinco años de antigüedad, la investigadora realizó un proceso de adaptación y modificación en octubre de 2025, dando lugar al instrumento denominado “Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño menor de 1 año”. Para garantizar su idoneidad, se llevó a cabo la validación y confiabilidad del instrumento mediante juicio de expertos con conocimientos y experiencia en la especialidad de Crecimiento y Desarrollo, el cuestionario final está compuesto por 27 ítems, organizados en tres dimensiones: factores socioeconómicos, factores culturales y factores institucionales. Cada ítem se responde mediante una escala dicotómica de Sí (1) y No (0), lo que permite identificar la presencia o ausencia de condiciones que podrían influir en la asistencia de las madres a los controles CRED, el instrumento se divide en 3 dimensiones,

factores socioeconómicos, factores culturales, factores institucionales, se categorizan de la siguiente manera:

Dimensión/variable	Ítems	Categorías/varemos
Variable Factores asociados	1-27	Bajo 0-8 Moderado 9-17 Alto 18-27
Dimensión socioeconómicos	factores 1-6	Bajo 0-1 Moderado 2-3 Alto 4-6
Dimensión Factores culturales	7-12	Bajo 0-1 Moderado 2-3 Alto 4-6
Dimensión institucionales	Factores 13-27	Bajo 0-4 Moderado 5-9 Alto 10-15

Instrumento 2. Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo:

el instrumento 2 fue desarrollado en base a la Norma Técnica De Salud Para El Control De Crecimiento Y Desarrollo Del Niño NTS 238 publicada en este año 2025 el 13 de octubre (57), donde me baso en el apartado 6.4 de la presente norma, donde establecen la frecuencia y numero de control de CRED para niños menores a un año, siendo 7 controles actualmente, este instrumento será medido solo basándonos en el cumplimiento acorde a la edad cronológica captada durante la ejecución del presente instrumento, de tal forma que si la madre evaluada tiene un niño de X edad, y al revisar su cartilla de controles

CRED, y no ha asistido de manera continua, ya no se considerara como cumplimiento, y tendrá valor de 0, pero si asiste de manera continua valdrá 1.

Dimensión/variable	Ítems	Categorías/varemos
Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo	7 controles.	Incumplimiento 0
		Cumplimiento 1

10.7.3. Validación

Validez de contenido Instrumento 1 Factores asociados al incumplimiento: La revisión del instrumento fue realizada por un panel conformado por: 1 enfermera especialista en cuidado materno infantil con mención en crecimiento y desarrollo, 2 enfermeras especialistas en cuidado integral infantil, 1 enfermera especialista en salud y desarrollo integral infantil con énfasis en control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones, 1 enfermera especialista en salud del niño y del adolescente y 1 enfermera especialista en salud pública con mención en epidemiología. Todas ellas evaluaron la coherencia, claridad y adecuación de cada ítem del cuestionario (ver en anexo 6).

Instrumento 2. Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo:

Para la medición del cumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo se utilizó el esquema oficial de controles establecido en la Norma Técnica de Salud NTS N.º 238-MINSA/DGIESP-2025, el cual constituye un instrumento normativo estandarizado y validado por el Ministerio de Salud para su aplicación en todo el territorio nacional. Por tratarse de un instrumento oficial ya validado y de uso obligatorio, no fue sometido a un nuevo proceso de validación por juicio de expertos, limitándose esta investigación a su utilización y correcta aplicación conforme a la norma vigente”.

10.7.4. Confiabilidad

La confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante el coeficiente Kuder–Richardson 20 (KR-20), por tratarse de un instrumento compuesto por ítems dicotómicos. Para este análisis, se realizó un estudio piloto con 20 participantes que presentaban características similares a la muestra definitiva, registrándose sus respuestas en una base de datos elaborada en Excel.

Aplicando la fórmula de KR-20, se obtuvo un coeficiente de 0.73, valor que se encuentra dentro del rango considerado aceptable (0.7–0.8). Este resultado indica que el instrumento posee una consistencia interna adecuada y es confiable para medir los factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de un año (ver en anexo 5).

Para el segundo instrumento al ser una normativa vigente, y publicada por el ministerio de salud del Perú, no lo he aplicado una prueba de confiabilidad estadística, porque no lo necesita, ya que es un documento estandarizado.

10.8. Plan de análisis:

Los datos se organizarán inicialmente en Excel para facilitar su estructuración y, posteriormente, se exportarán al programa estadístico IBM SPSS Statistics 26, donde se llevará a cabo la tabulación y el procesamiento. Este procedimiento permitirá generar tablas cruzadas y de evaluación con el fin de identificar posibles relaciones entre las variables, previo a estos análisis, se aplicará la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov, adecuada para muestras superiores a 50 participantes (en este caso, 83), con el propósito de determinar si los datos siguen una distribución normal, de acuerdo con los resultados, se seleccionará el tipo de prueba a emplear: se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson si los datos presentan normalidad, o el coeficiente Rho de Spearman si no cumplen con este supuesto.

Finalmente, se aplicará la prueba de chi cuadrado y se elaborarán tablas con distribuciones porcentuales, lo que permitirá interpretar los hallazgos de manera clara, precisa y ordenada.

10.9. Aspectos éticos y de integridad científica:

Este estudio se llevará a cabo con pleno respeto por los principios éticos esenciales y las pautas de conducta científica, asegurando tanto la salvaguarda de los derechos de quienes participen como la fiabilidad de los hallazgos. Se prestará especial atención a los aspectos relacionados con la bioética en la práctica profesional de enfermería. Antes de su implementación, la propuesta será evaluada y deberá contar con la autorización del Comité Institucional encargado de velar por la ética y la integridad en la investigación científica (CIEIC).

"Principio de autonomía

Se asegurará que la participación de las madres sea completamente voluntaria y basada en una decisión informada. Antes de integrarlas al estudio, se les explicarán claramente los objetivos, procedimientos, beneficios y posibles riesgos. Solo se incluirán aquellas que firmen el consentimiento informado, conforme a las normas del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC), garantizando que su aceptación sea libre y sin ningún tipo de coerción.

Principio de beneficencia

El estudio busca generar beneficios tanto para las madres participantes como para la comunidad, mediante el análisis de los factores que influyen en la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. Con base en los resultados, se plantearán estrategias que fortalezcan el cuidado infantil, garantizando en todo momento el bienestar y la integridad de las participantes.

Principio de no maleficencia

Se adoptarán medidas para proteger a las participantes de cualquier riesgo físico, emocional o psicológico. Los instrumentos se aplicarán en un ambiente seguro y privado por personal capacitado, asegurando la confidencialidad del proceso. Los datos recolectados serán manejados con total reserva y utilizados solo con fines académicos y de investigación.

Principio de justicia

La selección de las participantes se efectuará de manera justa, evitando cualquier tipo de discriminación por edad, nivel educativo, creencias, estado civil u otras condiciones personales. Todas las madres que cumplan los criterios establecidos tendrán igual oportunidad de participar, y los resultados se orientarán a favorecer el bienestar colectivo y generar beneficios para la comunidad.

11. Recursos y presupuestos: Este presupuesto contempla los recursos indispensables para el desarrollo de la tesis, estructurados según los rubros establecidos.

11.1. Equipos y bienes duraderos: La investigación requerirá herramientas tecnológicas básicas para el análisis de datos y, de ser necesario, acceso temporal a registros clínicos digitales o impresos, en caso que el centro de salud no facilite copias gratuitas. Software, servicio de internet.

11.2. Materiales e insumos: Se utilizarán cuadernos de apuntes, una memoria USB, bolígrafos, resaltadores y formatos para la recolección de información. También se contemplan impresiones de documentos como autorizaciones, consentimientos informados y fichas de observación. Además, se empleará material bibliográfico y científico, incluyendo libros de enfermería, artículos especializados y guías clínicas sobre el manejo de lesiones por presión.

11.3. Servicios de terceros: Asesoría metodológica externa y Procesamiento estadístico

11.4. Gastos de gestión y administrativos: Material bibliográfico, fotocopias, impresiones, viáticos.

Tabla 01. Recursos y presupuestos

TIPOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Honorario del investigador	200	1	200.00
Honorario estadístico	150	1	150.00
Honorario del encuestador	50	1	50.00
BIENES			
Equipo		1	1500.00
Software	100	1	100.00
Servicio de internet	30	5	150.00
Servicio técnico	50	1	50.00
SERVICIOS			
Material bibliográfico	50	4	200.00
Fotocopias	0.10	200	20.00
Impresiones	2	2	4.00
Viáticos de transporte publico	3.00	2	6.00
Desayuno y almuerzo	25	1	25
IMPREVISTOS			
TOTAL			2,455.00

1. Cronograma de actividades:

El desarrollo de estas actividades abarca desde el análisis de fuentes bibliográficas hasta la elaboración y presentación del trabajo final de tesis.

a). **Revisión de literatura:** Este proceso ofrece el marco teórico y los antecedentes necesarios para sustentar la investigación.

b). **Definición y planificación del diseño metodológico:** Se determinará una muestra compuesta por madres de niños menores de cinco años, especificando las variables de análisis y diseñando los instrumentos para la recopilación de información, tomando en cuenta los criterios éticos y operativos del establecimiento de salud.

c). **Recolección de datos:** Se aplicarán los instrumentos en el servicio de CRED, mediante una encuesta.

d). **Análisis de datos:** La información será analizada mediante software estadístico con el propósito de detectar y examinar los factores vinculados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de cinco años.

e). **Redacción y presentación de resultados:** Se redactará el informe definitivo con los hallazgos, conclusiones y sugerencias. Luego, se organizará la presentación para su defensa ante el comité evaluador.

Tabla 02. Cronograma de actividades

[illegible]

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y Niño Menor de Cinco Años. Lima: MINSA; 2017. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/ESRI/pdf/p_0004.pdf
2. Organización Mundial de la Salud. Seguimiento del crecimiento y el desarrollo del niño: informe técnico. Ginebra: OMS; 2003. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42624>
3. UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición: crecer bien en un mundo cambiante. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2019. Disponible en: <https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-11/Estado-mundial-de-la-infancia-2019.pdf>
4. Sierra L. Promoción del crecimiento y desarrollo en la primera infancia: buenas prácticas y lecciones aprendidas del programa Buen Inicio. Lima: UNICEF Perú; 2013. 298p. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/media/1856/file/Promoci%C3%B3n%20del%20crecimiento%20y%20desarrollo%20en%20la%20primera%20infancia.pdf>
5. Bhattarai M, Singh P, Saha A, et al. Factors influencing the use of health services for child growth monitoring in Nepal. BMC Nutr. 2024;10(1):27. doi:10.1186/s40795-024-00978-z.
6. Tadesse AW, Berhane H, Tilahun S. Barriers to using child growth monitoring services in rural areas of northwest Ethiopia. BMC Public Health. 2023;23(1):1-9. doi:10.1186/s12889-023-12422-0.
7. Ministerio de Salud del Perú. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano. Reporte de Seguimiento 2023-I. Lima: MINSA; 2023 [citado el 21 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/presupuestales/doc2024/reporte-seguimiento/Reporte%202023-I_PPoR%201001.pdf
8. Ministerio de Salud del Perú. Informe de evaluación institucional MINSA 2023. Lima: MINSA; 2023. Disponible en: <https://www.minsa.gob.pe/Recursos/OTRANS/14Informes/pei/Informe%20de%20evaluacion%20institucional%20MINSA%202023.pdf>

9. Orosco, C. L., & Ramirez, L. L. (2022). Factores socioculturales relacionados con inasistencia de madres al control de crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años en un centro de salud, Lima - 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. <https://hdl.handle.net/11537/33118>
10. Roldan, Y. F. (2022). Factores asociados al incumplimiento de las madres al control de crecimiento y desarrollo del niño(a) menor de un año en un centro de salud, Lima – Perú. 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. <https://hdl.handle.net/11537/35089>
11. Requejo Herrera CC. Factores que influyen en la inasistencia de las madres al control de crecimiento y desarrollo de los niños en el periodo 2012 – 2020 [Tesis de licenciatura]. Lima: Universidad César Vallejo; 2020. Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/74280>
12. Magallan Huamani AN. Factores asociados al incumplimiento de las madres en el control de crecimiento sano en niños menores de 5 años en un centro de salud, Perú 2024 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad César Vallejo; 2024. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/164186>
13. Quispe Quispe, Z. (2022). Factores relacionados al incumplimiento del control de cred en niños menores de cinco años, 2015-2020. Waynarroque - Revista De Ciencias Sociales Aplicadas, 2(3). Recuperado a partir de <https://unaj.edu.pe/revistacientificawaynarroque/index.php/rscaw/article/view/8>
14. Seijas Bernabé Nadia, Guevara Sánchez Ana Cecilia, Flores Castillo Vilma Altemira. Abandono del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 3 años del Hospital Santa Isabel - El Porvenir. Trujillo, La Libertad 2017. Horiz. Medicina. [Internet]. Enero de 2020 [consultado el 8 de junio de 2025]; 20(1): 12-19. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2020000100012&lng=es. <http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2020.v20n1.03>.
15. Córdor Heredia NT. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años - Piura, Perú, 2018. Rev Haban Cienc Méd. 2021;20(1):e3203.

16. Mphasha MH, Rapetsoa M, Mathebula N, Makua K, Mazibuko S. Non-adherence to growth monitoring and promotion sessions amongst caregivers of children under 5 years in Polokwane Municipality, Limpopo province. *S Afr Fam Pract* (2004). 2023 Feb 20;65(1):e1-e7. doi: 10.4102/safp.v65i1.5523. PMID: 36861913; PMCID: PMC9982518.
17. Simegn MB, Tilahun WM, Mazengia EM, Haimanot AB, Mneneh AL, Mengie MG, Endalew B, Birhanu MY, Tesfie TK, Asmare L, Geremew H. Growth monitoring and promotion service utilization and its associated factors among children less than two years in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2024 Nov 19;19(11):e0311531. doi: 10.1371/journal.pone.0311531. PMID: 39561142; PMCID: PMC11575828.
18. Dagne S, Aliyu J, Menber Y, Wassihun Y, Petrucka P, Fentahun N. Determinants of growth monitoring and promotion service utilization among children 0-23 months of age in northern Ethiopia: unmatched case-control study. *BMC Nutr*. 2021 Nov 8;7(1):67. doi: 10.1186/s40795-021-00470-y. PMID: 34743741; PMCID: PMC8573945.
19. Simachew Y, Abebe A, Yoseph A, Tsegaye B, Asnake G, Ali HH, Fikre R. Growth monitoring and promotion service utilization and its associated factors among mothers of children under two years in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pediatr*. 2024 Jul 19;24(1):463. doi: 10.1186/s12887-024-04946-1. PMID: 39030568; PMCID: PMC11264754.
20. Upadhyay, JP, Paneru, DP, Sharma, YP et al. Utilización y factores asociados de los servicios de monitorización y promoción del crecimiento en niños pequeños del distrito de Gorkha, Nepal. *BMC Nutr* 10 , 164 (2024). <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00978-z>
21. Seidu, F., Mogre, V., Yidana, A. et al. El uso de la monitorización y promoción del crecimiento es mayor en niños de 0 a 11 meses: una encuesta entre madres e hijos de zonas rurales del norte de Ghana. *BMC Public Health* 21, 910 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10980-w>
22. Girma D, Teshome D, kerie Y, Kaso AW, Kaso M. Growth monitoring and promotion services utilization and associated factors among children less than two years of age in Digelu Tijo district, south central Ethiopia. *Clinical Epidemiology and Global Health*. 2023; 19:101203.

23. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T. Epidemiología básica. 2. ed. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2006. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/43541>
24. World Health Organization. Guideline: Counselling of women to improve breastfeeding practices. Geneva: WHO; 2018.
25. Heredia-Pi IB, Serván-Mori E, Colchero MA. Inequidad en el acceso a los servicios de salud materno-infantil en América Latina: retos y oportunidades. Salud Publica Mex. 2019;61(6):787–95.
<https://doi.org/10.21149/10680>
26. Organización Mundial de la Salud. Determinantes sociales de la salud. Ginebra: OMS; 2010. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44264>
27. Bronfenbrenner U. The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press; 1979.
28. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2023. Lima: INEI; 2024 [citado 2025 may 21]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6389989/5601739-resumen-peru-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2023.pdf>
29. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional de Hogares 2023: Ingresos y Gastos. Lima: INEI; 2024 [citado 2025 may 21]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1537/cap10.pdf
30. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process. 1991;50(2):179–211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T
31. Rosenstock IM. Historical origins of the Health Belief Model. Health Education Monographs. 1974;2(4):328-335
32. Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.191
33. Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading (MA): Addison-Wesley; 1975.
34. Green LW, Kreuter MW. Health program planning: An educational and ecological approach. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2005.

35. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: Theory, research, and practice. 5th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2015.
36. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall; 1986.
37. Moreno Parrilla L. Programa de prevención en la salud: el uso de los videojuegos y sus efectos negativos a nivel conductual [Internet]. Universidad de las Islas Baleares; 2023 [citado 2025 Jun 4]. Disponible en: https://repositori.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/170346/Moreno_Parrilla_Lidia.pdf?sequence=1
38. Comité Editorial. Medicina Revista ICEST [Internet]. ICEST; 2025 [citado 2025 Jun 4]. Disponible en: <https://www.icest.edu.mx/media/5j0ps1zr/medicina-revista-icest-abril-2025.pdf>
39. Gestión de las artes escénicas y performativas [Internet]. Open Access UOC; 2016 [citado 2025 Jun 4]. Disponible en: <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/0ec2b5da-9335-4bd4-b249-16a98272148e/content>
40. Ministerio de Salud del Perú. Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030: “Perú, país saludable”. Lima: MINSA; 2020.
41. Díaz A, Rojas L. Factores laborales y adherencia a controles preventivos en población materno-infantil. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2022;39(1):88–95.
42. Organización Panamericana de la Salud. Equidad de género, roles familiares y acceso a la salud en América Latina. Washington, D.C.: OPS; 2019.
43. Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Informe sobre el gasto de bolsillo en salud de los hogares peruanos. Lima: MEF; 2021.
44. Ministerio de Salud (Perú). Norma Técnica de Salud N.º 238-MINSA/DGIESP-2025: Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño. Lima (PE): Ministerio de Salud; 2025.
45. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años. Lima: MINSA; 2017

46. Ministerio de Salud del Perú. Los controles de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años ayudan a detectar tempranamente la anemia y otras enfermedades. Lima: MINSA; 2024.
47. Gobierno del Perú. Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para menores de 5 años. Lima: MINSA; 2024.
48. Zevallos EPC. Factores que condicionan la asistencia al control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 1 año. Lima: UPCH; 2021
49. Carrasco-Escobar G, et al. Travel Time to Health Facilities as a Marker of Geographical Accessibility in Peru. PLoS One. 2020;15(1):e0228333.
50. Bleustein C, Rothschild D, Valen A, et al. Wait times, patient satisfaction scores, and the perception of care. Am J Manag Care. 2014;20(5):393-400.
51. McIntyre D, Thomson S, De Maeseneer J, et al. Waiting Time as an Indicator for Health Services Under Strain. Global Health Action. 2020;13(1):1729492.
52. Ferreira DC, et al. Patient Satisfaction with Healthcare Services and the Role of Provider's Attitudes. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(3):1908.
53. Hernández-Vásquez A, et al. Indigenous communities of Peru: Level of accessibility to health facilities. Int J Health Geogr. 2022;21:3.
54. Organización Mundial de la Salud. Calidad de la atención. Ginebra: OMS; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/quality-of-care>
55. Orem DE. Nursing: Conceptual, Theoretical and Practical Foundations. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 2011.
56. Roy C. The Roy Adaptation Model. In: Roy C, editor. The Roy Adaptation Model. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall; 2009
57. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud N.º 238-MINSA/DGIESP-2025: Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años. Lima: MINSA; 2025.
58. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años. Lima: MINSA; 2017.

59. Chahuas Rodríguez E. Factores de incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo del niño menor de un año en un establecimiento de salud público de Lima. Lima: Universidad Cayetano Heredia; 2017
60. Rosenstock IM. Historical origins of the Health Belief Model. *Health Educ Monogr.* 1974;2(4):328–35.
61. McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. An ecological perspective on health promotion programs. *Health Educ Q.* 1988;15(4):351–77. doi:10.1177/109019818801500401
62. Barlow J, et al. Understanding barriers to child health: a socio-ecological approach. *Pediatrics.* 2021;147(3):e2020010073.
63. Tello M, et al. Evaluación de la efectividad de programas de salud infantil en el cumplimiento de controles médicos. *Anales Salud Publica.* 2022;54(1):45–53. Disponible en: <https://www.scielo.org.pe>
64. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2021. Lima: INEI; 2022. Disponible en: <http://www.inei.gob.pe>
65. Cubillos L, et al. Determinantes económicos del incumplimiento de controles de crecimiento en niños menores de 5 años. *Rev Chil Pediatr.* 2020;91(4):516-23.
66. Cruz M, Montoya V, Suárez A, et al. Factores asociados al incumplimiento de controles de crecimiento y desarrollo en niños menores de un año. *Rev Peru Med Exp Salud Publica.* 2021;38(3):315–22. Disponible en: <https://www.rpmesp.upch.edu.pe>
67. Alarcón A, Díaz E, García P, et al. Cumplimiento de los controles de salud en niños menores de un año y sus determinantes en una población de Lima. *Rev Cienc Salud.* 2020;18(1):1–10. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5202/520252597003>
68. Tello M, Medina S, Barrios I, et al. Evaluación de la efectividad de programas de salud infantil en el cumplimiento de controles médicos. *Anales Salud Publica.* 2022;54(1):45–53. Disponible en: <https://www.scielo.org.pe>
69. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2021. Lima, Perú: INEI; 2022. Disponible en: <http://www.inei.gob.pe>

70. Barlow J, et al. Understanding barriers to child health: A socio-ecological approach. *Pediatrics*. 2021;147(3):e2021051725. Disponible en: <https://pediatrics.aappublications.org/content/147/3/e2021051725>
71. Henderson V. Las 14 Necesidades de Virginia Henderson en Enfermería [Internet]. *Enfermería Actual*; 2025 [citado 2025 Jun 4]. Disponible en: <https://enfermeriaactual.com/necesidades-basicas-de-virginia-henderson/>
72. Gonzales-Achuy E, Rojas-López J, et al. Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en niños menores de 5 años, región Amazonas. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2022;39(3):482-9.
73. Roy C. *The Roy Adaptation Model: Theory and Practice*. Springer; 2018.
74. Watson J. *Nursing: The Philosophy and Science of Caring*. University Press of Colorado; 2008.
75. Polit DF, Hungler BP. *Investigación científica en ciencias de la salud: principios y métodos*. 5ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 1999.
76. Hernández de Canales F. *Metodología de la investigación*. 3ª ed. México: Editorial Trillas; 2011. p. 77-78.
77. Hernández de Canales F. *Metodología de la investigación*. 3ª ed. México: Editorial Trillas; 2011. p. 93-96.
78. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio MP. *Metodología de la investigación*. 6ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2014.
79. Hernández-Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio M. *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. 6ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2014. p. 175-178.

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: FACTORES ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	Ítems	DISEÑO METODOLÓGICO
PROBLEMA GENERAL ¿Cómo los factores asociados se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025?	OBJETIVO GENERAL “Determinar Cómo los factores asociados se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”.	HIPOTESIS GENERAL H₁ (Hipótesis alternativa): Existe una relación entre los factores asociados y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025. H₀ (Hipótesis nula): No existe una relación entre los factores asociados y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.	VI: Factores asociados	Factores socioeconómicos. Factores culturales. Factores Institucionales.	-Condición laboral. -Actividades del hogar. -Gastos que representan al acudir al control. -creencias culturales. -creencias familiares. -creencias en la comunidad. -mitos. - tradiciones/creencias religiosas. -importancia de CRED -Horario de atención. -Tiempo de espera para ser atendido. -Tiempo de atención. -Trato del personal. -Distancia al centro de salud	1-6 7-12 13-27	-Tipo: Aplicada - Enfoque: Cuantitativo -Diseño: cuasiexperimental de corte transversal -Nivel: descriptico correlacional -Población: 100 madres -Muestra 85 madres
PROBLEMAS ESPECIFICOS ¿“Cómo la dimensión factores socioeconómicos se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año”? ¿“Cómo la dimensión factores culturales se relacionan con el incumplimiento del	OBJETIVOS ESPECIFICOS “Identificar cómo la dimensión factores socioeconómicos se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año” “Identificar cómo la dimensión factores culturales se relacionan	HIPOTESIS ESPECIFICAS H₁: Existe una relación entre la dimensión factores sociodemográficos y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en					

control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año”? ¿“Cómo la dimensión factores institucionales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año”?	con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año” “Identificar Cómo la dimensión factores institucionales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año”	madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025. H2: Existe una relación entre la dimensión factores culturales y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima , 2025. H3: Existe una relación entre la dimensión factores institucionales y el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025.	V2: Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo (CRED)	Esquema de controles oficiales de CRED según norma NTS 238	7 controles CRED	1-7
--	--	---	---	---	------------------	-----

ANEXO 2

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	
Título del Proyecto de Investigación: “Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”	
Autor Responsable: Paredes Aco, Karina Juliana	
Universidad /Institución: Universidad Privada Norbert Wiener	
I. INVITACIÓN	
Estimado(a) participante: Deseamos invitarle a contribuir en el desarrollo del siguiente proyecto de investigación, titulado: “Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”, desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. (UPNW). En las siguientes líneas encontrará una descripción completa del estudio y de lo que implica su colaboración.	
II. INFORMACIÓN	
2.1	Propósito del estudio: Objetivo general: - “Determinar Cómo los factores asociados se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025”. Objetivos específicos: - “Identificar cómo la dimensión factores socioeconómicos se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año” - “Identificar cómo la dimensión factores culturales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año” - “Identificar Cómo la dimensión factores institucionales se relacionan con el incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año” - Los resultados de esta investigación serán clave para optimizar las estrategias de atención en salud infantil, generar conocimiento relevante y mejorar la adherencia a los controles de crecimiento y desarrollo.
2.2	Duración del estudio: (09 meses)
2.3	Número esperado de participantes: 106 madres de niños menores de 1 año.
2.4	Criterios de Inclusión y exclusión Criterios de inclusión: - Madres mayores de 18 años y que asisten al Centro de Salud como posta adscrita para su atención. - Madres que acepten formar parte del estudio y hayan firmado de manera voluntaria su consentimiento informado

	- Ausencia de discapacidades mentales o físicas que interfieran con la participación. - Madres de niños menores de 1 año, pero mayores a los 28 días de nacido. - Ser usuarias del Centro de Salud. Criterios de exclusión - Madres de niños mayores de 1 año, y menores de 28 días de nacido. - Madres que no han iniciado los controles de CRED. - Madres que no hablen el idioma principal del estudio. - Madres con hijos que tengan condiciones médicas que no requieran controles de CRED. - Madres que no den su consentimiento informado.
2.5	Procedimientos del estudio: El cuestionario se llevará a cabo de forma presencial, en un espacio reservado y apropiado dentro del establecimiento de salud, que garantice privacidad y comodidad. Previo a su aplicación, se brindará una explicación sobre los objetivos del estudio y se pedirá al participante que firme el consentimiento informado. La duración estimada para completar la encuesta será de aproximadamente 10 a 12 minutos , se realizará de forma individual y estará orientada a evaluar los factores asociados al incumplimiento del control de CRED.
2.6	Riesgos: Estrés o ansiedad: Es posible que ciertas madres sientan preocupación al pensar si han asistido o no a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) de sus hijos. Riesgo social: Algunas madres podrían sentirse evaluadas o cuestionadas por sus decisiones.
2.7	Beneficios: Este estudio no solo beneficia directamente a las madres participantes , sino que también fortalece el conocimiento científico y mejora la calidad de atención en salud infantil.
2.8	Costos e incentivos: Su participación en este estudio no conlleva ningún tipo de gasto personal, ni se otorgarán retribuciones económicas o materiales por su colaboración.
2.9	Confidencialidad: Su información será codificada para proteger su identidad. Si los resultados del estudio se publican, no se incluirá ninguna información que permita identificarlo. Los datos estarán disponibles solo para el equipo de investigación.
2.10	Derechos del participante: Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalización o pérdida de derechos.
2.11	Preguntas/Contacto: En caso de que surjan dudas o comentarios, usted puede contactar directamente al investigador responsable: Karina Juliana Paredes Aco, teléfono: 944474105 y correo electrónico: a2020200935@uwiener.edu.pe “Asimismo, tiene la opción de comunicarse con el Comité de Ética que autorizó esta investigación por medio del Dr.(a) Angelica Karina Minaya Galarreta, presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW, al correo comite.etica@uwiener.edu.pe
2.12	Ocurrencias/Reclamos: En caso de existir alguna ocurrencia o reclamo, puede contactar al Comité de Ética que validó este estudio a través del Dr.(a) Angelica Karina Minaya Galarreta, presidente del Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la UPNW, al correo comite.etica@uwiener.edu.pe
III. DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO	

Declaro que he revisado y entendido la información contenida en el presente Formulario de Consentimiento Informado. Se me ha brindado una explicación comprensible acerca del propósito, metodología y objetivos de la investigación, y todas mis dudas han sido aclaradas satisfactoriamente. Reconozco que mi participación es libre y voluntaria, y que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento sin que esto implique consecuencia negativa alguna. Asimismo, se me entregará una copia firmada de este documento para mi resguardo.		
		___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
FIRMA DEL PARTICIPANTE Nombre del Participante: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	HUELLA DACTILAR	
		___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
FIRMA DEL AUTOR RESPONSABLE Nombre del Autor Responsable: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	HUELLA DACTILAR	
FIRMA DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (en caso corresponda) Nombre del Integrante del equipo de investigación: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	HUELLA DACTILAR	___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
FIRMA DEL TESTIGO/REPRESENTANTE LEGAL (en caso corresponda) Nombre del Testigo o Representante Legal: DNI/Carné de Extranjería/Otros:	HUELLA DACTILAR	___/___/202__. FECHA (dd/mm/aaaa)
NOTA: - Será necesario contar con la firma del testigo o del representante legal únicamente en aquellos casos en que la persona participante presente una discapacidad que le impida firmar, o no cuente con habilidades de lectura y escritura. - En caso se designe a otro miembro del equipo investigador para llevar a cabo la aplicación del consentimiento informado, este deberá estampar su firma en el presente documento. - Es importante tener presente que no se debe incluir como voluntarios a personas pertenecientes a poblaciones consideradas vulnerables como reclusos, militares, pueblos originarios, personas en situación de exclusión social, estudiantes o trabajadores que mantengan vínculos académicos o laborales con el investigador, a menos que el estudio esté específicamente orientado a generar beneficios directos para dichos grupos.		

ANEXO 3

CUESTIONARIO DE FACTORES ASOCIADOS E INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO MENOR DE 1 AÑO

INSTRUMENTO

Presentación:

Reciban un cordial saludo, Mi nombre es Karina Juliana Paredes Aco, estudiante de la carrera de Enfermería en la Universidad Norbert Wiener. En la actualidad, me encuentro elaborando una investigación titulada “Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de Salud de Lima, 2025”. Este cuestionario está orientado a madres con niños menores de un año que no han asistido de manera constante a las consultas de control de crecimiento y desarrollo en el mencionado centro de salud. A continuación, se presentan una serie de preguntas vinculadas con esta temática.

Los datos que usted brinde serán empleados únicamente con propósitos académicos, y permitirán analizar las causas que influyen en la asistencia o inasistencia de las madres a los controles de crecimiento y desarrollo de sus hijos menores de 1 año.

¿Está usted de acuerdo en participar en este estudio?

SI () NO ()

Habiendo dado su consentimiento voy a proceder hacerle las preguntas.

DATOS GENERALES

Sexo del niño: M () F ()

Edad.....

1. Edad de la madre:

a. Menor de 20 años () b. De 20 a 39 años () c. De 40 a 49 años ()

2. Estado Civil:

a. Soltera () b. Casada () c. Conviviente () d. Viuda () e. Divorciada

3. Número de hijos:

a. 1 hijo () b. 2 hijos () c. 3 hijos () d. más de 3 hijos ()

4. Grado de Instrucción:

a. Sin educación () b. Primaria () c. Secundaria () d. Técnico Superior () e. Universitario ()

5. Ocupación:

a. Ama de casa () b. trabajadora independiente () c. Obrera () d. Empleada ()

d. Profesional o técnica () e. Desempleada ()

6. Nacionalidad:

a. Peruana () b. Extranjera ()

7. Procedencia de nacimiento:

a. Costa () b. Sierra () c. Selva ()

N°	ENUNCIADOS	SI	NO
I. FACTORES SOCIOECONÓMICOS			
1	¿Actualmente cuenta con un empleo o fuente de ingreso económico estable?		
2	¿Su horario laboral le impide asistir con regularidad a los controles de crecimiento y desarrollo (CRED) de su niño?		
3	¿Sus quehaceres en el hogar limitan su tiempo para llevar a su niño a los controles CRED?		
4	¿El cuidado de otros hijos dificulta que acuda a los controles de crecimiento y desarrollo?		
5	¿Los gastos de transporte u otros costos relacionados representan una dificultad para asistir a los controles?		
6	¿Considera que la falta de apoyo económico familiar influye en su inasistencia a los controles de crecimiento y desarrollo?		
II. FACTORES CULTURALES			
7	¿En su familia se dice que "si el niño come bien y no llora, no necesita controles médicos"?		
8	¿Cree que los controles CRED son "cosa de doctores" y que las abuelas saben mejor cómo cuidar al niño?		

9	¿En su comunidad se piensa que los niños "se curan solos" o con remedios caseros sin necesidad de médicos?		
10	¿Considera que llevar al niño a controles regulares "tienta a la mala suerte" o al mal de ojo?		
11	¿En su tradición familiar, el crecimiento del niño depende más de "la bendición de Dios" que de visitas médicas?		
12	¿Piensa que los controles CRED son innecesarios si el niño "está fuerte y activo" como los niños de antes?		
III. FACTORES INSTITUCIONALES			
13	¿El horario de atención del centro de salud le resulta adecuado para asistir a los controles?		
14	¿Considera que el tiempo que la enfermera dedica a la atención de su niño es apropiado?		
15	¿El tiempo de espera, es un motivo por el cual no lleva a su niño a su control de crecimiento y desarrollo?		
16	¿El trato que recibe del personal de enfermería influye en su disposición a asistir a los controles?		
17	¿El trato del servicio de admisión cuando usted acude al centro de salud, es el motivo por el cual no lleva a su niño a su control?		

18	¿La distancia entre su domicilio y el centro de salud, es un motivo por el cual no lleva a su niño a sus controles?		
19	¿La enfermera del control de crecimiento y desarrollo le brinda información sobre la importancia del control?		
20	¿Ud. Considera que la información que recibe de la enfermera es clara y comprensible?		
21	¿La orientación que recibe en los controles le resulta útil para el cuidado de su niño?		
22	¿Considera que el número de profesionales de enfermería, en el área de CRED es suficiente para atender la demanda?		
23	¿La enfermera cumple con su horario de atención establecido?		
24	¿El ambiente del servicio CRED es llamativo, limpio y seguro para los niños?		
25	¿Considera que el material educativo entregado en los controles es útil para cuidar la salud de su niño?		
26	¿Percibe interés y amabilidad por parte de la enfermera durante su atención?		
27	¿La organización del servicio influye en su satisfacción y asistencia a los controles?		

ANEXO 4

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Cuestionario de: “ESQUEMA OFICIAL DE CONTROLES ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD NTS N.º 238-MINSA/DGIESP-2025”

CUESTIONARIO PARA VARIABLE:

“Incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo (CRED)

- b. Niños de 29 días hasta los 11 meses y 29 días:** siete (07) controles, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº controles	Edad	Frecuencia/Intervalo entre control
1º control	1 mes (29 a 59 días)	Mensual Intervalo mínimo de 30 días
2º control	2 meses (60 a 89 días)	
3º control	3 meses (90 a 119 días)	
4º control	4 meses (120 a 149 días)	Bimensual Intervalo mínimo de 60 días
5º control	6 meses (180 a 209 días)	Mensual Intervalo mínimo de 30 días
6º control	7 meses (210 a 239 días)	Bimensual Intervalo mínimo de 60 días
7º control	9 meses (270 a 299 días)	Último control de este grupo de edad

ANEXO 5

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

		Q-2	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-7	Q-8	Q-9	Q-10	Q-11	Q-12	Q-13	Q-14	Q-15	Q-16	Q-17	Q-18	Q-19	Q-20	Q-21	Q-23	Q-24	Q-25	Q-26		
Participante-1		0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
Participante-2		0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
Participante-3		0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Participante-4		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	13
Participante-5		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Participante-6		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Participante-7		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Participante-8		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Participante-9		0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	13
Participante-10		1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	13
Participante-11		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Participante-12		0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	15
Participante-13		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Participante-14		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Participante-15		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	12
Participante-16		0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	18
Participante-17		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	9
Participante-18		0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Participante-19		0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Participante-20		0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	19
TOTAL		1	3	3	2	5	19	20	2	20	0	17	19	19	7	8	8	3	19	20	20	17	18	17	19		
P		0.05	0.15	0.15	0.10	0.25	0.95	1.00	0.10	1.00	0.00	0.85	0.95	0.95	0.35	0.40	0.40	0.15	0.95	1.00	1.00	0.85	0.0	0.85	0.95		
q		0.95	0.85	0.85	0.90	0.75	0.05	0.00	0.90	0.00	1.00	0.15	0.05	0.05	0.65	0.60	0.60	0.85	0.05	0.00	0.00	0.15	0.10	0.15	0.05		
Σ(p*q)		0.05	0.13	0.13	0.09	0.19	0.05	0.00	0.09	0.00	0.00	0.13	0.05	0.05	0.23	0.24	0.24	0.13	0.05	0.00	0.00	0.13	0.09	0.13	0.05		
σ²		2.22																									
σ		1.49																									
K		24																									

$$\frac{k}{k-1} = 1.04$$

$$\left(1 - \frac{\sum pq}{\sigma^2_{total}}\right) = 0.70$$

$$K R20 = 0.73$$

$$K R20 = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum pq}{\sigma^2_{total}}\right)$$

KR-20	Interpretación
0,9 - 1	EXCELENTE
0,8 - 0,9	BUENA
0,7 - 0,8	ACEPTABLE
0,6 - 0,7	DEBIL
0,5 - 0,6	POBRE
<0,5	INACEPTABLE

ANEXO 6 VALIDACIÓN POR JUICIOS DE EXPERTOS

 **Universidad
Norbert Wiener**
Powered by Arizona State University®

UNIVERSIDAD PARTICULAR NORBERT WIENER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES
ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO**

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del informante:
..... LOZANO GONZALEZ MARIBEL

1.2 Cargo e institución donde labora
..... Lic. En Enfermería especialista en CRED / C.M.I. Manuel Barreto

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:
..... Instrumento Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en
madres de niños menores de 1 año

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

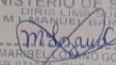
Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

Nº DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		
ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....

Lima 24 de 12 del 2025

 MINISTERIO DE SALUD
DIR. LIMA
C.M. MANUEL BARRETO

LIC. ESP. MANUEL LLANERO GONZALES
CER. 071071 RNE 17507

Firma del informante

DNI N° 10336179

Telf. 960774522



Universidad
Norbert Wiener
Powered by Arizona State University®

UNIVERSIDAD PARTICULAR NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES
ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO**

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del informante:

ABARCA QUIROZ ELIZABETH

1.2 Cargo e institución donde labora

LC. EN ENFERMERIA.

C.H.I. MANUEL BONNETO.

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

Instrumento Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en
madres de niños menores de 1 año

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		
ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		

SERVACIONES

.....
.....
.....
.....

 MINISTERIO DE SALUD
DIRIS LIMA SUR
C M I MANUEL GARRETO

Mg. Elizabeth Abarca Quiroz
.....
Mg. Elizabeth Abarca Quiroz
ENFERMERA ESPECIALISTA
C.E.R. N° 71047 - REE 020577

Lima 24. de 12. del 2025

Firma del informante

DNI N° 09111082

Telf: 965365412



Universidad
Norbert Wiener
Powered by Arizona State University[®]

UNIVERSIDAD PARTICULAR NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES
ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO**

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del informante:

ZOLA Elvira Cachay López

1.2 Cargo e institución donde labora

Coord. de Estrategias Sanitarias / CM Manuel Borja

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

Instrumento Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en
madres de niños menores de 1 año

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

Nº DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		
ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....

Lima 22 de 12 del 2025

MINISTERIO DE SALUD
DIRIS - LS - RIR - SJM
CMI - MANUEL BARRETO

.....
MG. ZOILA E. CACHAY LOPEZ
CEP-10888-111-001410-RE-18997

Firma del informante

DNI N° 06715704

Telf: 965662739.



Universidad
Norbert Wiener
Powered by Arizona State University®

UNIVERSIDAD PARTICULAR NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES
ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO**

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del informante:

Gaspar OSCO Floriza

1.2 Cargo e institución donde labora

Lic. en Enfermería en crecimiento y desarrollo / CMI Manuel Barreto

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

Instrumento Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en
madres de niños menores de 1 año

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

Nº DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		
ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....

Lima 20 de 12 del 2025

MINISTERIO DE SALUD
DIRIS - LIMA - G.O.P.
CMI MANUEL BARRETO
Lic. Esp. Florisa Gaspar Osce
CEP. 86929 RNEE. 075507

MINISTERIO DE SALUD
DIRIS - LIMA - G.O.P.
CMI MANUEL BARRETO
Lic. Esp. Florisa Gaspar Osce
CEP. 86929 RNEE. 075507

Firma del informante

DNI N° 41207179

Telf. 978.611.866



Universidad
Norbert Wiener
Powered by Arizona State University®

UNIVERSIDAD PARTICULAR NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES
ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO**

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del informante:

QUEZADA TRUJILLO, LUISA ESTHER

1.2 Cargo e institución donde labora

LIC. ENFERMERIA / C.H.I. MANUEL BARRETO

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

Instrumento Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en
madres de niños menores de 1 año

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		
ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....

Lima, 23 de 12 del 2025

MINISTERIO DE SALUD
C.M.I. CENTRO LIMA
LIC. ESP. LUISA E. ORZADA TRUJILLO
CEP. 871848 / A.N.E. 17384

Firma del informante

DNI N° 08549283

Telf: 964336422



Universidad
Norbert Wiener
Powered by Arizona State University®

UNIVERSIDAD PARTICULAR NORBERT WIENER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES
ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO**

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del informante:

.....SOFIA DEL CARPIO FLOREZ.....

1.2 Cargo e institución donde labora

.....EPIDEMIOLOGISTA - ISSALUD.....

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

.....Instrumento Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en
madres de niños menores de 1 año.....

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		
ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....

Lima, 22 de 12... del 2025


.....
Sig. **ROSALBA DEL CARMEN FLOREZ**
C. P. N° 9557-RE-N° 1911
DNI N° **71361**
JEF. DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD
HOSPITAL "LOS NEGRETIROS MEGA"
Telf. **956956890**
EsSalud

DNI= 08442934

Telf= 956956890

APROBACIÓN DE ENMIENDA

Lima, 10 de noviembre del 2025.

Autor Responsable:

PAREDES ACO, KARINA JULIANA

Exp. N°: 1408-2025

De mi consideración:

El Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC) de la Universidad Privada Norbert Wiener, tras evaluar la solicitud presentada, **APRUEBA LA ENMIENDA** del proyecto, originalmente titulado "Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año en un centro de salud de Lima, 2025." y aprobado por el CIEIC el 13/07/2025, Versión N° 1. El detalle de la enmienda se consigna en la sección "Cambios aprobados"; de ser el caso, se incorpora el nuevo título.

Autor(es):

PAREDES ACO, KARINA JULIANA

Cambios aprobados:

Se aprueba la modificación del lugar de investigación al Centro de Salud Mirones, se modificó la población y muestra. Dicha información también estará contemplada en cada fragmento del proyecto.

Alcance de la aprobación:

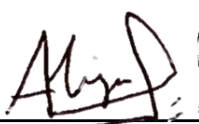
La aprobación de enmienda confirma que las modificaciones cumplen con las buenas prácticas éticas y no alteran el balance riesgo/beneficio, la idoneidad del equipo de investigación ni la confidencialidad de los datos previamente evaluados.

Obligaciones del investigador

- Esta aprobación no amplía ni modifica la vigencia otorgada en la constancia de aprobación inicial del proyecto; esta se mantiene en todo lo no modificado por la enmienda. Asimismo, los cambios rigen desde la fecha de emisión.
- Para fines administrativos o académicos, debe presentar ambos documentos: la constancia de /aprobación del proyecto y la constancia de aprobación de enmienda. Cualquier cambio adicional requiere nueva evaluación del CIEIC.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener

Lima, 28 de Noviembre de 2025

CARTA N° 605-2025-SG-UPNW-CP

Dra. Karina Ivonne Colmenares Otiniano.
Director General.
Coordinación de docencia e investigación, DIRIS Lima Centro.
Av. Nicolás de Piérola 589 – Lima cercado - Lima - Lima.

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentar a la estudiante del Programa Académico de **Enfermería; Karina Juliana Paredes Aco**, con código de matrícula **2020200935** con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos a 106 Madres de niños menores de 1 año que reciben atención en un Centro de salud de Lima, 2025.

Toda la información que solicita la tesista **Karina Juliana Paredes Aco**, para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **“Factores asociados al incumplimiento del control de crecimiento y desarrollo en madres de niños menores de 1 año de un centro de salud de Lima, 2025.”** dirigido por la asesora de tesis Mg. Sofia del Carpio Flórez., para la obtención del Título Profesional de Licenciada en Enfermería.

Agradeciendo por anticipado su autorización a la tesista para que logre su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Khristian Vigil Vega
DNI: 44025157
RUC: 20466246370
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/12/2025 Hora: 16:39:08